

Sub Appalto Specifico ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della Cartella Clinica Elettronica Regionale



HOW TO – CENTRO STELLA

Attività da fare durante l'avvio per macrotemi

ACN

SOMMARIO

1	Gestione segnalazioni.....	5
1.1	Segnalazioni per mancato allineamento ADT-NGH	6
1.2	Dimissioni in errore con ACK “Encounter with counter XXX doesn't join with patient unique identifier: YYY”	7
1.3	Segnalazione Consulta Storico non funzionante da Repository Nuvyta	7
2	Farmacia	8
2.1	Aggiungere codice AIC mancante in prontuario.....	8
2.1	Rimuovere codice AIC da prontuario	9
2.2	Dismettere un utente non più attivo dal portale regionale (tipo IDPC)	9
3	Utenti, ruoli, profili	9
3.1	Aggiungere utente mancante in portale regionale (tipo IDPC)	9
3.2	Associare un profilo all'utente da portale regionale	10
3.3	Abbassare al livello 2 l'autenticazione da portale regionale per il singolo utente	11
3.4	Abbassare al livello 1 l'autenticazione da portale regionale per il singolo utente	11
3.5	Abbassare al livello 2 l'autenticazione da portale regionale per tutti gli utenti (nel caso in cui non funzioni l'autenticazione IdPC).....	11
3.6	Aggiungere un profilo mancante su NGH	12
3.7	Modificare reparti associati al profilo	13
3.8	Modificare diritti su ruolo già esistente (con cautela!).....	14
3.9	Associare uno specifico tipo di ruolo a specifiche voci del catalogo per modificarne visibilità	14
3.10	Problema di accesso al portale che non dipende dalla configurazione dell'utenza sul portale	14
3.11	Creare un'utenza di backup per un reparto o un'area assistenziale	14
3.12	Resettare password di firma remota	15
3.13	Caricamento\estrazioni massive utenti	15
4	Prestazioni, esami.....	16
4.1	Aggiungere una prestazione mancante al catalogo degli esami e associare esame ad erogatore .	16
4.2	Modificare il codice di una prestazione	16
4.3	Modificare la descrizione di una prestazione	17
4.4	Aggiungere un nuovo profilo esami.....	17
4.5	Abilitare flag Quesito diagn. testuale obbligatorio nella voce del catalogo relativa all'esame	18
4.6	Associare un materiale già configurato ad un esame	18
4.7	Eliminare un esame associato al reparto errato.....	18
5	Erogatori/reparti.....	19
5.1	Aggiungere erogatore/reparto duale/area assistenziale mancante	19
5.2	Modificare il codice di un reparto (con cautela!).....	19

5.3	Modificare la descrizione/nome di un reparto	19
5.4	Modificare associazione tra reparto e area assistenziale	19
5.5	Disabilitare erogatori non più validi (con cautela!).....	20
6	Stanze e letti	20
6.1	Aggiungere stanza mancante al reparto.....	20
6.2	Aggiungere letto mancante al reparto	20
6.3	Modificare il codice della stanza o del letto	21
6.4	Modificare il nome della stanza o del letto	21
7	Altre configurazioni	21
7.1	Modificare intestazione LDO/richieste in stampa.....	21
7.2	Modificare spalla LDO in stampa	22
7.3	Intestazione referto ambulatoriale specifica per reparto.....	23
7.4	Aggiungere un parametro vitale mancante	24
7.5	Aggiungere nuova frase a frasario di reparto	25
7.6	Aggiungere nuovo tag paziente o episodio	30
7.7	Abilitare/disabilitare la scansione del braccialetto del paziente.....	30
7.8	Inserimento di valori decimali per un parametro vitale	31
7.9	Modificare l'intervallo temporale di somministrazione terapia	31
7.10	Consultazione note di diario importanti in compilazione di LDO	32
7.11	Protocollo parametri vitali/attività/schede configurato di default all'ingresso del paziente in reparto 32	
7.12	Aggiunta menu spalla in compilazione LDO.....	33
7.13	Correzione decodifica comuni in portale di reparto	33
7.14	Aggiungere parametro vitale nel menu a tendina per prescrizione di terapia al bisogno con parametro.....	33
7.15	Aggiungere protocollo terapeutico.....	34
7.16	Aggiungere/modificare parametri di default in maschera di rilevazione	35
7.17	Controllare corretta configurazione di una scala/scheda	36
7.18	NGH Continuity System.....	36
7.19	Aggiungere un'allergia non presente su NGH.....	37
7.20	Prescrizione terapia: dosaggio con virgola.....	37
7.21	Richieste esami limitate verso gli erogatori.....	38
7.22	Tipi di stampe cartella	40
7.23	Abilitare il tasto stampa per la lettera di trasferimento medica	40
7.24	Indice XML.....	41
7.25	Import documenti in CCE con riferimento al nosologico	42

8	Partogramma.....	42
8.1	Attivazione diritti.....	42
8.2	Catalogo: categoria partogramma	42
8.3	Parametri vitali	43
8.4	Catalogo: eventi cartella	44
8.5	Catalogo: dati entità cliniche	45
8.6	Catalogo: valori entità cliniche.....	47
8.7	Catalogo: entità cliniche.....	47
8.8	Configurazione schede parto, terzo stadio, quarto stadio	48
8.9	Configurazione anamnesi ostetrico-ginecologica	52
8.10	Configurazione esame obiettivo ostetrico-ginecologico	57
9	Flusso ambulatoriale	59
9.1	Configurazione prestazione ambulatoriale.....	59
9.2	Configurazione erogatore ambulatoriale.....	60
9.3	Configurazione agenda	60
9.4	Associazione erogatore ambulatoriale – referto ambulatoriale.....	61
9.5	Configurazione oscuramento referto ambulatoriale	62
9.6	Configurazione visita a metropolitana	62
10	Configurazione LIS (ASST FBF Sacco)	63
10.1	Configurazione di un esame-profilo a catalogo Esame.....	63
10.2	Associazione esame-erogatore (+ materiale + priorità).....	64
10.3	Configurazione etichette LIS	67
11	Supporto remoto ASST FBF Sacco: da sapere	67
11.1	Applicativi in uso nei diversi presidi e template ticket	67
11.2	Problemi comuni per ambulatoriale: duplicazione anagrafiche	69
12	Estrazione dati da Report manager.....	70

1 Gestione segnalazioni

Quando si verifica un problema in NGH che non è risolvibile internamente dal centro stella Accenture, è necessario aprire un ticket raccogliendo prima le informazioni riguardanti la segnalazione:

scrivo per effettuare una segnalazione che riguarda il progetto Aria CCE.

1-Denominazione della struttura:

2-Criticità del problema (bassa, media, alta, critica):

3-Riferimenti dell'utente finale (Cognome, Nome, tipo profilo):

4-Numero di telefono dell'utente finale:

5-Reparto o unità operativa di servizio:

6-Descrizione dettagliata dell'anomalia rilevata o della richiesta formulata, inclusi eventuali screenshot non tagliati, oscurati di eventuali dati sensibili:

7-Azioni necessarie per replicare il problema, inclusi eventuali nominativi dei pazienti coinvolti:

8- CF dei pazienti coinvolti:

A chi indirizzare il ticket in base alla problematica:

- per le segnalazioni riguardanti i problemi di **integrazioni in orario 9-18 da lunedì a venerdì** (paziente dimesso da ADT ma ancora visibile nel portale di reparto, paziente accettato da ADT ma non visibile nel portale di reparto, posto letto assegnato da ADT ma non visibile in CCE), è necessario effettuare un primo check interno con il team supporto Accenture ingaggiabile tramite Andrea Abatantuono (contatti: andrea.abatantuono@accenture.com, 3421354303); includere le informazioni reperite da ADT circa data e ora degli eventi in errore (accettazione, dimissione, etc.);
- per le segnalazioni riguardanti i problemi di **integrazioni in orario nelle restanti fasce** è necessario supportare gli utenti nell'apertura del ticket tramite fleet (1° livello di Assistenza) degli Enti.
- Per gestire dubbi e/o configurazioni: contattare direttamente Alessia Sorrenti di GPI (+393421695671, alessia.sorrenti@gpi.it).
- per eventuali migliorie applicative: contattare direttamente Andrea Mascheroni di GPI (+39 3423866115, andrea.mascheroni@gpi.it)
- Per estrazioni dal DB inviare richiesta via mail a ccerl@gpi.it
- per tutte le altre tipologie di segnalazioni è necessario supportare gli utenti un ticket tramite fleet (1° livello di Assistenza) degli Enti.
- per segnalazioni relative a Galileo inviare mail direttamente a support@dedalus.eu mettendo siso.sacco@asst-fbf-sacco.it in CC.

Le segnalazioni devono essere gestite tramite il fleet (1° livello di Assistenza) di ciascun Ente successivamente inoltrate a GPI.

Ente	Email	Telefono	Modalità di attivazione Fleet
Fleet ASST Melegnano	sd@bcs.it	800971784 (in verifica)	Mail o chiamata

Fleet ASST Crema	h.desk@asst-crema.it	800940741	Mail o chiamata
Fleet ASST Lariana	fleet.lariana@nord-com.it	800610233	
Fleet ASST Valtellina	fleet.valtellina@nord-com.it	800610105	Mail o chiamata
Fleet ASST FBF Sacco	sd@bcs.it	800971783	interno 2794 solo FBF interno 7305 Sacco Buzzi
Fleet ASST Pavia	hdsstpavia@bcs.it	800811196	

N.B. Per ASST Lariana, ASST Valtellina, ASST Pavia continuare a gestire le richieste di segnalazione verso GPI anche direttamente, mantenendo la modalità di invio verso il fleet, che inoltrerà verso il supporto GPI nei casi previsti.

GPI PRODUCTS – piattaforma di GPI di tracciamento ticket

Link: <https://gpiproductsext.gpi.it/gpiproducts/pages/login.jsf>

Credenziali per ente:

	Nome utente	Password
ASST Melegnano	e12711	GpiProducts005
ASST Crema	e12754	CCEAccenture12345
ASST FBF Sacco	e12711	GpiProducts005
ASST Lariana	e12711	GpiProducts005
ASST Pavia	e12711	GpiProducts005
ASST Valtellina	e12711	GpiProducts005

1.1 Segnalazioni per mancato allineamento ADT-NGH

Per problemi di integrazione, quando non si vede il paziente su NGH, mandare una mail all'indirizzo sopra riportato con il seguente testo:

Oggetto: mancata sincronizzazione ADT-NGH

Buongiorno,

scrivo per effettuare una segnalazione che riguarda Aria CCE.

Denominazione della struttura: Ospedale <nome ospedale>;

Criticità del problema: URGENTE;

Riferimenti dell'utente finale: infermiere/medico con profilo <nome del profilo che vedono cliccando sull'omino in alto a destra>;

Reparto o unità operativa di servizio: <reparto>;

Descrizione dettagliata dell'anomalia rilevata: IL PAZ CON NOSOLOGICO <nosologico> E CF <CF del

paziente> è PRESENTE SU ADT MA NON RISULTA PRESENTE SU NGH
Vi chiediamo di sanare la problematica quanto prima possibile.

Saluti

1.2 Dimissioni in errore con ACK “Encounter with counter XXX doesn't join with patient unique identifier: YYY”

Caso specifico ospedale Sacco:

Se in seguito a una segnalazione per paziente dimesso da ADT ma ancora presente in CCE l'assistenza risponde con un ACK negativo per il messaggio A03 di dimissione di questo tipo:

Encounter with counter 2025104849 doesn't join with patient unique identifier: SWY703@52251

Questi sono i successivi passaggi da fare:

- 1) Chiedere all'assistenza (Abatantuono o sacco.support) di fornirci il messaggio ADT^A40 di merge anagrafico e il relativo ACK di errore.
- 2) L'ACK di errore dell'A40 sarà probabilmente del tipo: t.gpi.his.be.ejb.entities.catalogs.HealthDistrict not found for contextKey: ANAGRAFICA\S\SACCO and code: 030727 >> Significa che nel catalogo “ASL di riferimento” di NGH non è presente il codice ASL 030727 che abbiamo ricevuto da ADT nel messaggio.
- 3) Andare su CCE come super amministratore in Configurazioni >> Cataloghi >> ASL di riferimento e aggiungere codice e descrizione dell'ASL che genera l'errore. Per capire quale è la descrizione corrispondente al codice, provare queste strade:
 - Cercare nel file excel di decodifica fornito dall'Ente e caricato su Teams: [COMUNI-ASL \(2\).xlsx](#)
 - Cercare il codice nel catalogo ASL di riferimento di un altro ente di cui abbiamo accesso all'ambiente.
 - Se i due tentativi sopra non sono andati a buon fine, provare a cercare su internet “asl XXXXXX” e vedere se esce un risultato ragionevole. Per vedere se è coerente un metodo può essere verificare col codice fiscale del paziente se il luogo di nascita coincide con quanto trovato su internet per l'ASL (controllo non sempre affidabile ma può aiutare).
- 4) Una volta effettuata la configurazione su NGH, rispondere ad Abatantuono/sacco.support informandoli della cosa e chiedendo di riprocessare i messaggi ADT A40 e A03 (NEW: il presidiante riprocessa in autonomia dalla GUI).
- 5) Una volta che il supporto ha riprocessato i messaggi con ACK positivi, verificare in CCE che il paziente sia passato dal portale di reparto ai dimessi e informare l'ente.

1.3 Segnalazione Consulta Storico non funzionante da Repository Nuvyta

In caso di segnalazione per malfunzionamento della funzionalità ‘Consulta Storico’ accessibile dal Repository Nuvyta, occorre contattare il team ACN (Daniele De Marco) e fargli verificare la corretta configurazione del widget Siss Way che deve presentare la dicitura ‘Homepage’.

Per verificare il corretto funzionamento del Consulta Storico, che permette di aprire in contesto da NGH il fascicolo del paziente e quindi avere accesso a tutto l'archivio documentale del paziente, occorre aprire ‘Repository Nuvyta’, cliccare l'icona in alto a destra di Consulta storico (icona documenti), dare l'accesso SISS, chiudere la schermata che si apre come da indicazione mostrata nella pagina, e verificare di essere nella schermata di NPRI.

2 Farmacia

2.1 Aggiungere codice AIC mancante in prontuario

Farsi dare dal personale di reparto il codice AIC del farmaco mancante (e se possibile la foto della scatola), cercare in Farmadati (<https://medicinali.aifa.gov.it/#/it/>) tramite codice AIC la descrizione completa corrispondente al codice AIC fornito.

- a) Farmaco disponibile su Farmadati: Su NGH andare in Configurazioni --> Opzioni --> Formulario --> Vai! --> [PTO] Prontuario. Per aggiungere un singolo farmaco cliccare sul tasto + e inserire nel box "Immetti parziale o totale Prodotto" la descrizione del farmaco e selezionare la voce corrispondente alla descrizione completa trovata su Farmadati corrispondente all'AIC fornito. Cliccare su "Salva". Controllare tramite il box "Filtra..." che il farmaco appena inserito in prontuario tramite descrizione corrisponda effettivamente al codice AIC fornito dal personale di reparto.

PRONTUARIO

Codice PTO	Ordinamento 	Codice esterno PTO
Descrizione Italiano Prontuario		
Tipi Ruolo abilitati Aggiungi filtro per Tipo Ruolo		
Tipo HOSPITAL		
Tutti Form obbligatoria Mostra eliminati		

Prontuario

Ricerca Prodotto		Immetti parziale o totale Prodotto		Vai!
Codice drugdb 	Codice farmacia 	Unità di misura 		
Disponibile ☒	Consegna alla dimissione ☐	Form obbligatoria ☐	Chiusura terapia ☒	
Modulo richiesta 			Giorni di validità 	
			Annulla Salva	

- b) Farmaco non disponibile su Farmadati: segnalare a GPI che il farmaco richiesto dal personale di reparto non è registrato su Farmadati e quindi non è configurabile su NGH.

2.1 Rimuovere codice AIC da prontuario

Farsi dare dal personale di reparto il codice AIC del farmaco da rimuovere (e se possibile la foto della scatola), cercare in Farmadati (<https://medicinali.aifa.gov.it/#/it/>) tramite codice AIC la descrizione completa corrispondente al codice AIC fornito.

Su NGH andare in Configurazioni --> Opzioni --> Formulario --> Vai! --> [PTO] Prontuario. Cercare il farmaco tramite il box "Filtra..." e cliccare l'icona "Elimina" della riga corrispondente.

Codice drugdb	Prodotto farmaceutico	Codice farmacia	Modulo richiesta	Disponibile	Consegna alla dimissione	Unità di misura	
016805095	SERENASE*OS GTT 15ML 2MG/ML (ALOPERIDOLO) [GOCCE ORALI SOLUZIONE]			Si	No		

2.2 Dismettere un utente non più attivo dal portale regionale (tipo IDPC)

Quando un utente va in pensione o si dimette, è necessario dismettere la sua utenza da portale regionale.

Collegarsi al portale di Regione Lombardia del relativo Ente e selezionare dal menu "Configurazioni" la voce "Gestione utenti". Cercare l'utente con la barra di ricerca e spegnere il flag "Attivo" che si trova in alto a destra rendendolo "Disattivo".

Registrare l'utente che si è appena disattivato nell'apposito file Excel di dismissione utenti per l'Ente in questione (sul Pdf >> Ente >> Assessment >> Utenti >> CCE_Dismissione_Utenti_ENTE.xlsx). Il referente di questa attività per ogni Ente dovrà inviare mensilmente l'elenco delle utenze da dismettere da Portale a luca.scevola@gpi.it, che si occuperà di eliminare definitivamente dal Portale le utenze non più attive.

3 Utenti, ruoli, profili

3.1 Aggiungere utente mancante in portale regionale (tipo IDPC)

Prima di aggiungere un nuovo utente nel portale di Regione, è necessario avere la conferma dai Sistemi Informativi dell'Ente a procedere. Inviare quindi una mail al referente SIA comunicando che da reparto ci è stato segnalato che l'utente XXX dovrebbe accedere a NGH per il reparto YYY; chiedere conferma per i profili da associare all'utente. Referenti SIA per ogni Ente:

ASST Crema: Daniela Soloni >>> d.soloni@asst-crema.it

ASST Melegnano: Daniela Marino >>> daniela.marino@asst-melegnano-martesana.it

ASST Lariana: XXX

ASST Valtellina: XXX

ASST FBF Sacco: Antonella Pugliese e Alessandro Crupi >>> antonella.pugliese@asst-fbf-sacco.it e alessandro.crupi@asst-fbf-sacco.it

Farsi dare dall'Ente i seguenti dati dell'utente non censito sul portale regionale: cognome, nome, codice fiscale, email aziendale, Idap, ruolo (medico, infermiere, OSS, ...) e reparto su cui deve avere visibilità. Collegarsi al portale di Regione Lombardia e selezionare dal menu "Configurazioni" la voce "Gestione utenti".

Cliccare il tasto “Aggiungi utente” e inserire i dati anagrafici forniti. Come nome utente inserire il codice fiscale e come tipo utente selezionare **IDPC**, poi cliccare “Salva”. Cercare sul portale l’utente appena inserito, selezionarlo e aprire il tab “Applicativi e ruoli”: espandere la riga corrispondente a NGH, cliccare sul tasto “Assegna ruolo” e cercare il ruolo da assegnare all’utente. Selezionare la voce corrispondente al ruolo cercato e cliccare sul tasto “Assegna”. Spostarsi sul tab “Attributi aggiuntivi” e dal menu a tendina selezionare “Ruolo utente”: se l’utente è un medico assegnare “DOCTOR”, altrimenti “NURSE”. Infine, accendere il flag in alto a destra nella schermata dell’utente, che da “Disattivo” deve diventare “Attivo”.

Nella sezione “Credenziali” inserire cf in minuscolo, lasciando il flag “Provvisoria” attivo.

Nel caso in cui sia presente, aggiornare il file di utenti totale (si trova sul Portale della Fornitura in Documents >> Ente Sanitario in cui si sta lavorando >> Assessments >> Utenti >> file caricamento utenti totale) aggiungendo una nuova riga per l’utente appena censito.

APP

▼

Applicazioni

CONFIGURAZIONI

▼

Gestione utenti

Configurazione portale

Gestione profili

Nuovo utente

Nome utente *

Cognome *

Nome *

Codice Fiscale *

Email *

Telefono

Tipo utente *

IDPC

Salva

3.2 Associare un profilo all’utente da portale regionale

Prima di aggiungere un nuovo utente nel portale di Regione, è necessario avere la conferma dai Sistemi Informativi dell’Ente a procedere. Inviare quindi una mail al referente SIA comunicando che da reparto ci è stato segnalato che l’utente XXX dovrebbe accedere a NGH per il reparto YYY; chiedere conferma per i profili da associare all’utente. Referenti SIA per ogni Ente:

ASST Crema: Daniela Soloni >>> d.soloni@asst-crema.it

ASST Melegnano: Daniela Marino >>> daniela.marino@asst-melegnano-martesana.it

ASST Lariana: pnrr@asst-lariana.it

ASST Valtellina: XXX

ASST FBF Sacco: XXX

Collegarsi al portale di Regione Lombardia e selezionare dal menu “Configurazioni” la voce “Gestione utenti”. Cercare dal box “Filtra...” il nome dell’utente e selezionarlo. Entrare nel tab “Applicativi e ruoli”: espandere la riga corrispondente a NGH, cliccare sul tasto “Assegna ruolo” e cercare il ruolo da assegnare all’utente. Selezionare la voce corrispondente al ruolo cercato e cliccare sul tasto “Assegna”.

Se all’utente non era assegnato alcun profilo NGH, andare anche nel tab “Attributi aggiuntivi” e popolare il campo “Ruolo utente” con DOCTOR/NURSE a seconda che l’utente sia medico/infermiere e il campo “Username LDAP” con quello che appare prima della @ nell’email aziendale dell’utente.

Nel caso in cui sia presente, aggiornare il file di utenti totale (si trova sul Portale della Fornitura in Documents >> Ente Sanitario in cui si sta lavorando >> Assessments >> Utenti >> file caricamento utenti totale) aggiungendo una nuova riga per l'utente appena censito.

Dati utente	Credenziali	Applicativi e ruoli	Attributi aggiuntivi				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Stato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▼ NGH</td> <td>Assegnato</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Stato	▼ NGH	Assegnato		
Nome	Stato						
▼ NGH	Assegnato						
Cerca per nome o per ruolo...		Assegna ruolo					

3.3 Abbassare al livello 2 l'autenticazione da portale regionale per il singolo utente

Dall'interfaccia del portale regionale, andare in Gestione Utenti e selezionare l'utente. In Credenziali, inserire i flag come di seguito:

Attivazione locale: ON

OTP: ON

Le credenziali con cui l'utente dovrà entrare sono:

Username: CF

Password: quella impostata al primo accesso

OTP: Google authenticator

3.4 Abbassare al livello 1 l'autenticazione da portale regionale per il singolo utente

Dall'interfaccia del portale regionale, andare in Gestione Utenti e selezionare l'utente. In Credenziali, inserire i flag come di seguito:

Attivazione locale: ON

OTP: OFF

Le credenziali con cui l'utente dovrà entrare sono:

Username: CF

Password: quella impostata al primo accesso

3.5 Abbassare al livello 2 l'autenticazione da portale regionale per tutti gli utenti (nel caso in cui non funzioni l'autenticazione IdPC)

Collegarsi al portale di Regione Lombardia e selezionare dal menu "Configurazioni" la voce "Configurazione portale". Spegner il flag "IdPC abilitato".

CONFIGURAZIONI	
- Gestione utenti Configurazione portale - Gestione profili	☒ IdPC abilitato

Come si firmano i documenti (LDO, referti di consulenza, ecc.) quando la firma remota non funziona?

Quando le utenze sono abbassate al livello 2, non è possibile apporre la firma remota sui documenti prodotti in cartella. Quindi, in questo caso, va indicato di stampare il documento cartaceo e temporaneamente apporre la **firma autografa**.

A chi segnalare il problema di IDPC down?

Oltre a segnalare la problematica sul gruppo whatsapp per le segnalazioni, va aperto un ticket al fleet dell'Ente, in modo che possano dirottare loro il ticket ad ARIA:

Ente	Email	Telefono
Fleet ASST Melegnano	sd@sntx.it	800971784
Fleet ASST Crema	h.desk@asst-crema.it	800811194
Fleet ASST Lariana	da inserire riferimenti fleet	
Fleet ASST Valtellina	fleet.valtellina@nord-com.it	800610105
Fleet ASST Sacco	da inserire riferimenti fleet	800971783
Fleet ASST Pavia	da inserire riferimenti fleet	

3.6 Aggiungere un profilo mancante su NGH

Su NGH andare in **Configurazioni --> Utenti e permessi --> Profili utenti**.

- Cliccare sul tasto +.
- Inserire in “**Codice profilo**” un nuovo codice per il profilo mancante (seguire possibilmente lo stesso formato dei codici già esistenti, quindi ad esempio CRE_REPARTO_REP_MED per i medici, CRE_REPARTO_DEG_INF/OSS per gli infermieri/OSS dell'Ospedale Maggiore di Crema).
- Inserire in “**Descrizione profilo**” la descrizione per il profilo mancante (seguire possibilmente lo stesso formato delle descrizioni già esistenti, quindi Medico - NomeReparto Crema, Infermiere – NomeReparto Crema, ...).
- Selezionare come “**Tipo di ruolo**” quello adatto.
- Accendere il flag “**Vista assistenziale**” per i profili che devono avere visibilità assistenziale, quindi infermieri, OSS, ecc. Non compilare le date di inizio e fine validità del profilo.
- In “**Reparti**” cliccare sulla lente di ingrandimento e selezionare il/i reparto/i su cui il profilo deve avere visibilità.
- Popolare il box “**Reparto di contesto**” con lo stesso reparto (o uno dei reparti) selezionato sopra.
- In “**Ruoli utente**” cliccare sulla lente di ingrandimento e selezionare il ruolo corrispondente al profilo creato.
- Cliccare **Salva**, il profilo è creato su NGH

Dopo aver creato il profilo su NGH, va fatto l'allineamento dei profili da portale regionale.

- Collegarsi al portale di Regione Lombardia e selezionare dal menu “Configurazioni” la voce “**Gestione profili**” e nel tab “Allineamento profili” dal menu a tendina selezionare “**ngh**” e cliccare il tasto “**Allinea profili**”. Attendere che compaia un box dal riquadro verde con scritto che l'allineamento dei profili è avvenuto con successo.

PROFILO CONDIVISO **NUOVO PROFILO**



CODICE PROFILO

CODICE OBBLIGATORIO

NOME PROFILO

NOME OBBLIGATORIO

TIPO DI RUOLO



TIPO DI RUOLO OBBLIGATORIO

DATA INIZIO VALIDITÀ

DATA FINE VALIDITÀ

VISTA

ASSISTENZIALE



DETTAGLI PROFILO

REPARTI

Visualizzati 0/0 Elementi



Codice	Nome	Modalità	Modifica
--------	------	----------	----------

Allineamento profili

Assegnazione profili

ngh

Allinea profili

3.7 Modificare reparti associati al profilo

Su NGH andare in Configurazioni --> Utenti e permessi --> Profili utenti. Tramite il box "Cerca..." cercare il profilo di interesse e selezionarlo. Nella sezione "Reparti" eliminare tramite il tasto corrispondente la riga relativa al reparto che va eventualmente rimosso, mentre per aggiungere un nuovo reparto da associare al profilo cliccare sulla lente di ingrandimento e selezionare il/i reparto/i su cui il profilo deve avere visibilità. Popolare il box "Reparto di contesto" con lo stesso reparto (o uno dei reparti) selezionato sopra.

DETTAGLI PROFILO

REPARTI

Visualizzati 0/0 Elementi



Codice	Nome	Modalità	Modifica
--------	------	----------	----------

Reparto di Contesto

3.8 Modificare diritti su ruolo già esistente (con cautela!)

Su NGH andare in Configurazioni --> Utenti e permessi --> Ruoli utente. Scegliere il ruolo di interesse e cercare il diritto da modificare, usando un codice o una descrizione (per esempio, se sto cercando i diritti legati alle richieste, posso cercare nella barra “rich” e verranno fuori i diritti legati alle richieste).

RICERCA PERMESSI

Cerca (codici, descrizioni)

Mostra solo attivi ☐

Visualizza chiavi ☐

Per aggiungere il modulo “Partogramma”, abilitare il diritto MODULEFOLDER_PARTOGRAPH.

Per aggiungere modulo Repository

3.9 Associare uno specifico tipo di ruolo a specifiche voci del catalogo per modificarne visibilità

Su NGH andare in Configurazioni --> Cataloghi. Cercare il catalogo relativo alla voce che si vuole modificare e scegliere la voce. Nel campo **Tipi Ruolo abilitati** inserire il tipo di ruolo.

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

3.10 Problema di accesso al portale che non dipende dalla configurazione dell'utenza sul portale

Se l'utente riscontra un problema nell'accesso al portale, ma effettuando un controllo sul portale la configurazione è corretta in tutte le parti, viene inviata segnalazione all'Ente (fleet), in modo che l'Ente faccia un controllo lato pdA/pdR ed eventualmente invii una segnalazione ad ARIA.

3.11 Creare un'utenza di backup per un reparto o un'area assistenziale

Bisogna creare utente sul portale 4.0 specifico del cliente; quindi, andare in Gestione utenti → Aggiungi utente. L'utente deve avere un codice fiscale vero quindi usare il generatore con il nome e cognome che ho inserito. Il nome e cognome configurarlo “parlante” sul reparto. Ad esempio, se devo fare backup su Neurologia, creare nome utente continuityneurologia, nome Neurologia, Cognome Chiari, mail: neurologia-chiari@chiari.it. Mettere accesso locale e tipo utente locale e generare una password sul generatore di password (non provvisoria). Aggiungere il profilo medico (se reparto duale/erogatore) o infermiere (se area assistenziale) relativo al reparto o all'area. Aggiungere anche l'attributo Nurse o Doctor.

Togliere OTP e fare un primo accesso al portale e alla cartella con l'utenza appena creata (importante accedere proprio alla cartella e non limitarsi all'accesso al portale).

Inviare mail a Paolo Russian paolo.russian@gpi.it e Paolo Spadoni paolo.spadoni@gpi.it (in cc Luca Scevola luca.scevola@gpi.it e Matteo Sportelli matteo.sportelli@gpi.it) indicando l'username dell'utenza creata e codice del reparto, chiedendo di rimuovere definitivamente l'OTP e aggiungere il reparto al menu del client di continuità.

3.12 Resettare password di firma remota

Andare su Aruba selfcare – firma remota: <https://selfcare.firma-remota.it/asmonitor/login.xhtml>

Cliccare su Recupero password. Come “codice utente” va inserito un codice alfanumerico che l’utente ha ricevuto in una mail (o sull’indirizzo personale o sull’indirizzo aziendale) con oggetto “Firma remota”. Come “nome utente” va inserito OTP_CF/TK_CF seguito da (tutto attaccato) @frLispa. Fare “Prosegui” e seguire le indicazioni per il reset della password.

3.13 Caricamento\estrazioni massive utenti

GPI ha comunicato oggi che a partire dal 01/02/26 **e solo per Portal4** ai fini di tenere meglio traccia delle attività di caricamento\estrazioni massive utenti etc. si richiede di utilizzare, per queste attività, la seguente modalità di richiesta:

Aprire su GPI Products una attività con le seguenti informazioni:

Tipologia: Supporto

Team: F_MDW_PORT

Effort: Per caricamenti <50 utenti 1 ora, per caricamenti >50 utenti 2 ore, per estrazioni massive 1 ora.

Se obbligatorio inserire come risorsa: Vito Alfredo Ficocelli.

Nel caso in cui si tratti di un caricamento massivo allegare il file degli utenti.

Considerando l'impossibilità per i PM non GPI di inserire attività in GPI Products e con l'obiettivo di centralizzare questo tipo di attività per un miglior governo delle attività, in caso di richieste per attività di caricamento\estrazioni massive utenti chiediamo a tutti i PM di inviare una mail a ccerl@gpi.it indicando:

CASO 1: estrazione massiva

OGGETTO = CCE RL -ESTRAZIONE MASSIVA UTENTI [CLIENTE]

CORPO = Si richiede l'estrazione massiva degli utente DETTAGLIO DELL'ESTRAZIONE. L'attività ha priorità ALTA/MEDIA/BASSA, se possibile si richiede il completamento dell'attività entro dd/mm.

CASO 2: caricamento massivo

OGGETTO = CCE RL -CARICAMENTO MASSIVO UTENTI [CLIENTE]

CORPO = In allegato file contenente i nominativi da caricare sul Portale 4.0 del cliente NOME_CLIENTE. L'attività ha priorità ALTA/MEDIA/BASSA, se possibile si richiede il completamento dell'attività entro dd/mm.

ALLEGATO = file con elenco utenti da inserire

Qualora nelle richieste non siano specificate priorità e data di completamento dell'attività, il ticket assumerà di default priorità bassa e verrà data una scadenza temporale pari ad una settimana dalla ricezione della richiesta.

4 Prestazioni, esami

4.1 Aggiungere una prestazione mancante al catalogo degli esami e associare esame ad erogatore

Su NGH andare in Configurazioni --> Cataloghi e cercare il catalogo "Esame". Cliccare il tasto + per inserire un nuovo esame. Compilare il campo codice e descrizione con i dati forniti dall'Ente. Per il campo "Tipo esame" selezionare dal menu a tendina [01] Erogazione base per tutte le prestazioni RIS, LIS, AP, selezionare [02] Consulenza per una prestazione di consulenza. Compilare i campi "Tempo di preparazione", "Durata", "Tempo di uscita" con i valori rispettivamente di 0-30-0. Accendere il flag "Prestazione richiedibile solo con qta=1". Se richiesto, accendere il flag "Quesito diagn. testuale obbligatorio". Cliccare il tasto "Salva".

ESAME (EXAM)

Codice	Ordinamento		
Codice obbligatorio			
Descrizione Italiano			
Descrizione Italiano obbligatorio			
Valido dal	Valido al		
Tipo esame	Specializzazione	Exam per il risultato iniziale	
	examMedicalSpecialization		
Tempo di preparazione	Durata	Tempo di uscita	Giorni soglia in post-ricovero
			30
Preparazione obbligatoria	Durata obbligatoria	Uscita obbligatoria	
Codice regionale	Codice nazionale	Procedura riferimento	
Priorità assegnata	Somministrazione farmaco	Need ambiguous	Need serological equivalent
Priorità assegnata			
Prescription step enabled	Prestazione richiedibile solo con qta = 1	Abilita esito prericovero	Quesito diagnostico obbligatorio
Quesito diagn. testuale obbligatorio	Ripetibile	Abilita raccolta consenso	Materiale obbligatorio

Per associare l'esame al rispettivo erogatore, su NGH andare in Configurazioni --> Struttura ospedaliera --> Reparti. Selezionare l'Ospedale e cercare tramite il box "Cerca..." l'erogatore/reparto a cui va associato l'esame appena configurato. Selezionare l'erogatore, e scorrere in fondo fino al tab "Esami". Selezionare il tasto +, cercare l'esame che si vuole associare all'erogatore tramite il box "Cod/Descr...", selezionarlo tramite il bottone "Selezionato" e cliccare ""Salva". Cliccare il tasto "Salva" anche nella schermata del reparto.

Esami	Diagnosi	Operazioni	Parametri Vitali	Attività	Protocolli	Vie di Somministrazione	Preparati	Valori Custom
Context keys	Obgettività	Sintomi	Parametri dell'organizzazione	Turni	Medico assegnabile	Tipi di dieta	Categoria Note	
Categoria appuntamento		Motivo di inserimento in lista di attesa ambulatoriale			Primario di reparto			

4.2 Modificare il codice di una prestazione

(con cautela!) Su NGH andare in Configurazioni --> Cataloghi e cercare il catalogo "Esame". Cercare tramite il box "Cerca..." l'esame in questione e selezionarlo. Modificare il codice inserito nel campo "Codice" e cliccare "Salva".

ESAME (EXAM)

Codice

Codice obbligatorio

4.3 Modificare la descrizione di una prestazione

Su NGH andare in Configurazioni --> Cataloghi e cercare il catalogo "Esame". Cercare tramite il box "Cerca..." l'esame in questione e selezionarlo. Modificare la descrizione inserita nel campo "Descrizione Italiano" e cliccare "Salva".

Descrizione Italiano

Descrizione Italiano obbligatorio

4.4 Aggiungere un nuovo profilo esami

Su NGH andare in Configurazioni → Opzioni → Profili. Cliccare su + e compilare i campi obbligatori. Sotto la voce Esami, cliccare su + per aggiungere gli esami al profilo.

PROFILO

Codice

Codice obbligatorio

Ordinamento

Descrizione Italiano

Descrizione Italiano obbligatorio

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo profilo

Generico

Tipologia episodio

Tipologia episodio

Priorità assegnata

Priorità assegnata

Colore

Scegli un colore

Colore

Scegli un colore

RICHIEDENTI



Codice



Nome



ESAMI



4.5 Abilitare flag Quesito diagn. testuale obbligatorio nella voce del catalogo relativa all'esame

Su NGH andare in Configurazioni --> Cataloghi e cercare il catalogo "Esame". Cliccare sulla riga relativa all'esame di interesse e abilitare il flag "Quesito diagn. testuale obbligatorio".

Quesito diagn. testuale obbligatorio



4.6 Associare un materiale già configurato ad un esame

Su NGH andare in Configurazioni --> Cataloghi e cercare il catalogo "Esame". Cliccare sulla riga relativa all'esame di interesse e sotto Materiale (in basso nella schermata), cercare il materiale di interesse dal menu, selezionarlo e cliccare Aggiungi. È possibile aggiungere più di un materiale ad uno stesso esame; uno di questi può essere reso di default inserendo la spunta su Default.

4.7 Eliminare un esame associato al reparto errato

Su **NGH** andare in **Configurazioni**, selezionare il Box **Struttura Ospedaliera** quindi la sezione **Reparti**. Nel box **Ricerca**, cercare il reparto di interesse (ad es. Radiologia FBF). Nella pagina che si apre, scorrere fino in fondo e cliccare su **Esami** all'interno del riquadro con i vari box. Nel riquadro **Filtra**, inserire il codice dell'esame (ad es. RIS0188774.1) e nella riga corrispondente, cliccare sull'icona a forma di **X** per eliminare l'esame. Cliccare infine su **Salva** per confermare e salvare la modifica fatta.

5 Erogatori/reparti

5.1 Aggiungere erogatore/reparto duale/area assistenziale mancante

Su NGH andare in Configurazioni → Struttura ospedaliera → Struttura. Sotto il livello Hospital, cliccare + per aggiungere un nuovo punto di erogazione. Compilare campi obbligatori.

Flag da abilitare: **Integrazione HL7, Abilita erogazione visite ambulatoriali, Abilita prericovero, Abilita terapia**

Tipo Reparto

Tipo Radiologia, Laboratorio, Anatomia Patologica

ASST CREMA > OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA > OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA ▼

Codice: 03020900 Abbr: OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA Livello: HOSPITAL

Nome Italiano: OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Codice Fiscale: Valuta: Attivo: Partenza per ricerca lista d'attesa:

Indirizzo: Largo Dossena N: 2 CAP: 26013

Città: [019035] Crema Paese: country Catalogo Prontuario: [PTO_2] Prontuario_2

Rimuovi Salva

Punti di erogazione	Stanza	Settori	Chiusure	Valori custom	Parametri dell'organizzazione		
Codice	Modalità	Nome	Descrizione	Valido Da	Valido A	Numero letti	Sposta

5.2 Modificare il codice di un reparto (con cautela!)

Su NGH andare in Configurazioni → Struttura ospedaliera → Struttura. Sotto il livello Hospital, cliccare icona della matita sulla riga del reparto che si intende modificare.

Codice	Modalità	Nome	Descrizione	Valido Da	Valido A	Numero letti	Sposta
0801	Modalità duale	Cardiologia	Cardiologia				

5.3 Modificare la descrizione/nome di un reparto

Su NGH andare in Configurazioni → Struttura ospedaliera → Struttura. Sotto il livello Hospital, cliccare icona della matita sulla riga del reparto che si intende modificare.

Codice	Modalità	Nome	Descrizione	Valido Da	Valido A	Numero letti	Sposta
0801	Modalità duale	Cardiologia	Cardiologia				

5.4 Modificare associazione tra reparto e area assistenziale

Su NGH andare in Configurazioni → Struttura ospedaliera → Struttura. Sotto il livello Hospital, cliccare icona della matita sulla riga dell'area assistenziale che si intende modificare. Nella sezione Reparti, è possibile aggiungere/rimuovere un reparto.

Reparti	
Erogatore	Elimina

5.5 Disabilitare erogatori non più validi (con cautela!)

Su NGH andare in Configurazioni → Struttura ospedaliera → Struttura. Sotto il livello Hospital, cliccare icona della matita sulla riga dell'erogatore che si intende modificare. Inserire una data di fine validità nel campo **Valido A**. L'erogatore sarà comunque visibile nella lista degli erogatori in struttura. Per riabilitare un erogatore, è necessario contattare team GPI.

Valido A



6 Stanze e letti

6.1 Aggiungere stanza mancante al reparto

In questo caso, prima di fare modifiche, è importante assicurarsi che la configurazione stanze-letti di NGH sia allineata con quella presente sull'ADT dell'Ente.

Su NGH andare in Configurazioni → Struttura ospedaliera → Stanze – letti. Selezionare l'hospital. Cliccare su + (Crea stanza). Compilare i campi obbligatori.

Compilare anche il campo "Posizione" inserendo il numero di stanza: questo campo va compilato per fare in modo che nel portale di reparto i pazienti siano correttamente ordinati in ordine di letto crescente.

Stanza

Codice Codice obbligatorio	Nome Descrizione obbligatorio	Reparto 
Posizione 	Telefono 	Piano
N. letti Numero di letti obbligatorio	N. letti virtuali Numero di letti virtuali obbligatorio	Sesso della stanza Basato sul sesso del primo paziente
Tipo stanza 	Attiva ☒	Indietro Salva

Su n. letti e n. letti virtuali inserire valore "50" per non creare limitazione nell'inserimento dei letti successivamente.

6.2 Aggiungere letto mancante al reparto

In questo caso, prima di fare modifiche, è importante assicurarsi che la configurazione stanze-letti di NGH sia allineata con quella presente sull'ADT dell'Ente.

Su NGH andare in Configurazioni → Struttura ospedaliera → Stanze – letti. Selezionare l'hospital. Cercare e selezionare la stanza in cui inserire il nuovo letto cliccando sull'icona della lente e cliccare su +. Compilare i campi obbligatori.

Come “Tipologia” selezionare “Letto standard” se non è specificato diversamente.

Compilare anche il campo “Posizione” inserendo il numero di letto: questo campo va compilato per fare in modo che nel portale di reparto i pazienti siano correttamente ordinati in ordine di letto crescente.

6.3 [Modificare il codice della stanza o del letto](#)

In questo caso, prima di fare modifiche, è importante assicurarsi che la configurazione stanze-letti di NGH sia allineata con quella presente sull'ADT dell'Ente.

(con cautela!): Su NGH andare in Configurazioni → Struttura ospedaliera → Stanze – letti. Selezionare l'hospital. Cercare e selezionare la stanza, cercare il letto da modificare e cliccarci sopra per aprire il modulo di inserimento per eseguire le modifiche.

6.4 [Modificare il nome della stanza o del letto](#)

Su NGH andare in Configurazioni → Struttura ospedaliera → Stanze – letti. Selezionare l'hospital. Cercare e selezionare la stanza, cercare il letto da modificare e cliccarci sopra per aprire il modulo di inserimento per eseguire le modifiche nei campi che si vuole modificare.

7 Altre configurazioni

7.1 [Modificare intestazione LDO/richieste in stampa](#)

Su NGH andare in Configurazioni → Struttura ospedaliera → Struttura. Sotto hospital, si inserisce l'intestazione in Valori custom, con la chiave “report-intestazione” e valore corrispondente al contenuto dell'intestazione.

Per ogni reparto, il contenuto dell'intestazione va inserito nel box **Informazioni aggiuntive**. Poi, cliccare **Salva**.

Punti di erogazione	Stanza	Settori	Chiusure	Valori custom	Parametri dell'organizzazione

Valido Da	Valido A		
e-mail	Centro di costo logistico	Centro di costo amministrativo	
Specializzazione Medica [08] CARDIOLOGIA	Tipo di cartella [08] Cardiologia		
Tipologia trattamento			
Informazioni aggiuntive			
Ruoli abilitati all'invio delle richieste Aggiungi filtro per Tipo Ruolo		Ruoli abilitati alla cancellazione delle richieste Aggiungi filtro per Tipo Ruolo	

Per verificare che l'intestazione sia stata configurata correttamente, in ambiente di TEST bisogna compilare una nuova versione di LDO su un paziente di prova. Salvare tale versione con "Definitivo senza firma". Nel modulo "Documenti", bisogna fare una prova di stampa che è anche possibile scaricare.

MODO ALTERNATIVO: Su NGH andare in Configurazioni → Struttura Ospedaliera → Reparti → cercare reparto da modificare → in fondo alla pagina, nella parte con i vari box selezionare quello contenente la dicitura Valori custom → in fondo si apre una sezione che contiene il testo della spalla della LDO e per la modifica del contenuto e del testo si seguono le istruzioni al paragrafo 7.2 → Infine, cliccare Salva per modificare definitivamente la spalla.

Se ci viene richiesto di modificare l'intestazione della LDO per un solo reparto, ad esempio: solo per il reparto ODC SASSI configurato sotto l'OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO, nell'intestazione della LDO vorrebbero inserire la dicitura "Ospedale di Comunità Sassi, ASST Fatebenefratelli Sacco" invece del nome dell'Hospital che NGH pesca in automatico.

Si fa così: tramite report-intestazioneCustom all'interno della ldo-configuration per il reparto.

Per il caso specifico, occorre procedere come segue:

Chiave = ldo-configuration

Valore = {"report-intestazioneCustom" : "NOME OSPEDALE
PERSONALIZZATO
Intestazione custom ospedale"}

dove per "intestazione custom ospedale" si intendono le informazioni relative alla sede legale, ecc., che in questo caso sono:

Sede Legale: Via G.B Grassi, 74. 20157 - Milano | CF e PI:09319690963 IBAN: IT04W0306901603100000046207 protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Esempio per ODC Sassi dell'ASST FBF Sacco:

valore = {"report-intestazioneCustom" : "Ospedale di Comunità Sassi, ASST Fatebenefratelli Sacco
Sede Legale: Via G.B Grassi, 74 . 20157 - Milano | CF e PI:09319690963 IBAN: IT04W0306901603100000046207 protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it"}

7.2 Modificare spalla LDO in stampa

Su NGH andare in Configurazioni → Struttura ospedaliera → Reparti → livello cercare il reparto di interesse. Per ogni reparto, la spalla va aggiunta in Valori custom, con la chiave "report-spalla" e valore corrispondente al contenuto della spalla scritto in html.

Esami	Diagnosi	Operazioni	Parametri Vitali	Attività	Protocolli	Vie di Somministrazione	Preparati	Valori Custom	Context keys	Oggettività	Sintomi	Parametri dell'organizzazione	Turni
Medico assegnabile	Tipi di dieta	Categoria Note	Categoria appuntamento	Motivo di inserimento in lista di attesa ambulatoriale	Primario di reparto								



Alcune indicazioni su scrittura in html:

Testo di esempio = Il testo "Testo di esempio" comparirà in **grassetto** nella stampa

**
** = Consente di andare accapo

Esempio:

**Unità Operativa Complessa Neurologia-Stroke Unit
Direttore:
Dott. Luigi Caputi
e-mail: neurologia@asst-crema.it
Tel. 0373 280387
Direttore:
Dott. L. Caputi**

Nella stampa della LDO comparirà nella spalla del documento in questo modo:

Unità Operativa Complessa Neurologia-Stroke Unit Direttore: Dott. Luigi Caputi e-mail: neurologia@asst- crema.it Tel. 0373 280387	Pi Ni Ro
Direttore: Dott. L. Caputi	Si gi Di

Per verificare che l'intestazione e la spalla siano state configurate correttamente, in ambiente di TEST bisogna compilare una nuova versione di LDO su un paziente di prova. Salvare tale versione con "Definitivo senza firma". Nel modulo "Documenti", fare una prova di stampa che è anche possibile scaricare.

7.3 Intestazione referto ambulatoriale specifica per reparto

Come per la lettera di dimissione, sarà possibile tramite parametro personalizzare alcuni aspetti del referto. Stampa con spalla o stanza senza spalla (shoulder)

Campi del referto obbligatori (requiredFields)

Il testo della spalla (report-spalla)

Per la stampa con spalla, come per la lettera di dimissione, sarà possibile definire sub-header e report-primario

Altro valore configurabile è l'intestazione della stampa, questo parametro sarà possibile configurarlo, tramite il customValue report-intestazioneSP-refAmbu, a livello di singolo reparto in alternativa sarà scelta l'intestazione a livello di Hospital.

La configurazione sarà su 3 livelli con diverse livelli di priorità

Agenda (livello prioritario)

ServicePoint (livello intermedio)

Hospital (livello basso)

Esempio di configurazione da aggiungere nei CUSTOM VALUE del livello desiderato (agenda, servicePoint,

```
hospital)
ref_ambulatoriale-configuration : {
"requiredFields":["anamnesi_anamnesi","esameObiettivo_esameObiettivo"],
"report-primario":"Dott. NomeCognome",
"shoulder":true,
"report-spalla": "<b>Test Report Spalla</b> <br> MedicoNome MedicoCognome" ,
"subHeader":"SPECIALIZATION o SERVICEPOINT"
}
```

report-intestazioneSP-refAmbu : Intestazione Personalizzata reparto
 MedicoNome
MedicoCognome

I campi da poter inserire nei requiredFields sono:

Descrizione campo	Codice campo
Quesito Diagnostico	<u>quesitoDiagnostico</u>
Anamnesi	<u>anamnesi_anamnesi</u>
Allergie	<u>anamnesi_allergie</u>
Esame Obiettivo	<u>esameObiettivo_esameObiettivo</u>
Prestazione Eseguita	<u>esameObiettivo_prestazioneEseguita</u>
Confronto con precedenti esami eseguiti	<u>precedentiEsami</u>
Referto	<u>diagnosiReferto_referto</u>
Diagnosi	<u>diagnosiReferto_diagnosi</u>
Suggerimenti per il medico prescrittore	<u>diagnosiReferto_suggerimentiPerMedico</u>
Accertamento consigliato	<u>diagnosiReferto_accertamento</u>
Terapia Consigliata	<u>terapiaConsigliata</u>
Conclusioni	conclusioni
Note	note

7.4 Aggiungere un parametro vitale mancante

Su NGH andare in Configurazioni → Opzioni → Parametri vitali. Come “Categoria” selezionare “Parametri primari”.

Questa configurazione si può fare solamente in seguito a un passaggio con l’Ente: se l’Ente vuole aggiungere un nuovo parametro vitale in ambiente, deve fare richiesta a Regione e solo dopo si potrà configurare.

7.5 Aggiungere nuova frase a frasario di reparto

Su NGH andare in Configurazioni → Opzioni → Templates. Per creare una nuova categoria, cliccare + e compilare i campi in base alla necessità. Per aggiungere una frase alla categoria, si seleziona la categoria dall'elenco e si clicca sul + (aggiungi modello). Compilare almeno codice, titolo, descrizione (con il contenuto della frase) e categoria.

FRASARI LDO

La configurazione avviene da configurazioni → opzioni → templates

- **Definizione del Frasario (Template)**
per ogni campo della LDO che prevede un frasario è stato definito un codice:

EXAMSOB --> ESAME OBIETTIVO ALL'INGRESSO

PROCEDURES --> INTERVENTI CHIRURGICI

CLINICALCOURSE --> DECORSO CLINICO E TERAPIA DURANTE IL RICOVERO

CONDIZIONI --> CONDIZIONI ALLA DIMISSION

PROBLEMIAPERTI --> PROBLEMI APERTI

PROBLEMICHIIUSI --> PROBLEMI CHIUSI

EXPREV --> CONTROLLI SUCCESSIVI

OTHERPRESCRIPTIONS --> ALTRE PRESCRIZIONI E ALTRE INDICAZIONI ALLA DIMISSIONE

TREATMENTPLANSEXPONENTS --> PIANI TERAPEUTICI ED ESENZIONI

Per creare un frasario vanno indicati:

- codice strutturato come segue (es. in immagine)
(es. LDO_CLINICALCOURSE)
- la descrizione italiano (mettere il nome del campo della LDO, es.
Decorso clinico)
- l'indicazione "scheda FM3" = true

- **Definizione delle frasi associate al Frasario**

per ogni frasario è possibile definire "n" frasi, tali frasi devono avere:

- un codice, strutturato come segue (es. in immagine)
(es. LDO_CLINICALCOURSE_001)
- il titolo (può essere tutta o una parte della descrizione, serve per far riconoscere il contenuto della descrizione)
- la descrizione italiano (mettere il "Titoletto" - "Frase" presenti nel file
(es. Arti inferiori e spalle - Regolare. Profilassi antibiotica e
. Terapia antalgica.)
- Ordinamento: mettere l'ordine a ciascuna frase in modo che siano ordinate in ordine alfabetico in base alla specialità.
- la categoria template (dovrebbe già essere selezionata)
- la specializzazione medica

Per mostrare le frasi solo ad una specialità indicarla nel campo "specializzazione medica". Ad oggi NGH 8.6 non consente di associare delle frasi ad uno specifico reparto.

Non indicando alcuna specialità tutte le frasi saranno visibili da tutte le specialità.

Templates

Utenti e permessi Opzioni Interfaccia Struttura ospedaliera Form e star

RICERCA CATEGORIA TEMPLATE

Cerca... Vali +

Implanto di device

FRASARIO - DIARIO

Decorso clinico

CAR - LDO - Altre prescrizioni e altre indicazioni alla dimissione

5 / 4 Prima 1 Ultima

RICERCA MODELLO

Cerca... Vali +

Regolare. Profilassi antibiotica e antitrombotica. Terapia antalgica.

5 / 1 Prima 1 Ultima

TEMPLATE

Codice LDO_CLINICALCOURSE_001 Ordinamento

TITOLO ITALIANO
Regolare. Profilassi antibiotica e antitrombotica. Terapia antalgica.

TITOLO INGLESE

Descrizione Italiano
Regolare. Profilassi antibiotica e antitrombotica. Terapia antalgica.

Descrizione Inglese

Categorie template
Decorso clinico Categorie template
Specializzazione Medica
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Specializzazione Medica
Agende
Add a tag
Tipi Ruolo abilitati
Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Frasario Anamnesi:

Per ogni anamnesi va configurato:

Frasario (template) indicando:

- Tipi di template: "Nota anamnesi familiare e sociale visita"
- Reparti: quelli che si vogliono abilitare
- Tipo anamnesi: la specifica anamnesi

Esempi sotto:

Templates

Utenti e permessi Opzioni Interfaccia Struttura ospedali

RICERCA CATEGORIA TEMPLATE

Cerca... Vali +

Frasario Diario

Anamnesi Familiare

Anamnesi prossima

Anamnesi Remota

Anamnesi sociale

5 / 18 Prima 1 2 3 4 Ultima

RICERCA MODELLO

Cerca... Vali +

Anamnesi familiare 1 bis

5 / 1 Prima 1 Ultima

TEMPLATECATEGORY

Codice ANA_FAM Ordinamento

Descrizione Italiano
Anamnesi Familiare

Descrizione Inglese

Tipi Ruolo abilitati
Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipi template
Nota anamnesi familiare e sociale visita Tipi template

Reparti
NCH 1 - Neurochirurgia I - Neurochirurgia Oncologica Add a tag

Tipo Anamnesi
[FAMILIAR] Familiare x

Schede FM3

Per ogni template poi si configurano le frasi (modelli):

Risultato finale:

Frasari referto ambulatoriale

Per il referto ambulatoriale seguire i seguenti passaggi (identici alla LDO):

Definizione del Frasario (Template)

per ogni campo del referto amb che prevede un frasario è stato definito un codice:

REFAMB_CONCLUSIONI → CONCLUSIONI

REFAMB_REF → DIAGNOSI/REFERTO

Per creare un frasario vanno indicati:

- codice strutturato come segue (es. in immagine)

REFAMB_CodiceDelCampo (es. REFAMB_CONCLUSIONI)

- la descrizione italiano (mettere il nome del campo della LDO, es. Decorso clinico)

- l'indicazione "scheda FM3" = true

RICERCA CATEGORIA TEMPLATE

REFAMB_CONCLUSIONI

Conclusioni

5 / 1

Prima

1

Ultima

RICERCA MODELLO

Cerca...

Prosegue con la terapia in corso

5 / 1

Prima

1

Ultima

TEMPLATECATEGORY

Codice

REFAMB_CONCLUSIONI

Ordinamento

Descrizione Italiano

Conclusioni

Descrizione Inglese

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Schede FM3

Elimina

Salva

Definizione delle frasi associate al Frasario

per ogni frasario è possibile definire “n” frasi, tali frasi devono avere:

- un codice, strutturato come segue (es. in immagine)

REFAMB_CodiceDelCampo_NumeroProgressivo (es. REFAMB_CONCLUSIONI_001)

- il titolo (può essere tutta o una parte della descrizione, serve per far riconoscere il contenuto della descrizione)

- la descrizione italiano (mettere il “Titoletto” - “Frase” (es. Arti inferiori e spalle - Regolare. Profilassi antibiotica e antitromboembolica. Terapia antalgica.

aggiungendo alla fine il tag html
 così da mandare a capo ogni frase che il medico deciderà di aggiungere)

- Ordinamento: mettere l’ordine a ciascuna frase in modo che siano ordinate in ordine alfabetico in base alla specialità.

- la categoria template (dovrebbe già essere selezionata)

- la specializzazione medica

Per mostrare le frasi solo ad una specialità indicarla nel campo “specializzazione medica”.

Non indicando alcuna specialità tutte le frasi saranno visibili da tutte le specialità.

Templates

Utenti e permessi

Opzioni

Interfaccia

Struttura ospedaliera

Form e stampe

Cataloghi

Opzioni avanzate

RICERCA CATEGORIA TEMPLATE

conclusioni

Conclusioni

5 / 1

Prima

1

Ultima

RICERCA MODELLO

Cerca...

Prosegue con la terapia in corso

5 / 1

Prima

1

Ultima

TEMPLATE

Codice

REFAMB_CONCLUSIONI_001

Ordinamento

Titolo Italiano

Prosegue con la terapia in corso

Titolo Inglese

Descrizione Italiano

Prosegue con la terapia in corso

Descrizione Inglese

Categorie template

Conclusioni

Categorie template

Specializzazione Medica

CARENCOLOGIA

Specializzazione Medica

Agende

Add a tag

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Elimina

Salva

Risultato:

7.6 Aggiungere nuovo tag paziente o episodio

Su NGH andare in Configurazioni → Cataloghi → TagEntry, cliccare su +. Compilare i campi obbligatori e il campo **Tipo Tag** in base a dove il tag deve essere reso disponibile.

IN PIU' (non necessario): Se si vuole configurare l'assegnazione automatica di un tag (ad esempio in seguito a un punteggio ottenuto nella compilazione di una scala), accendere il flag "Assegnato da tag engine". Andare poi in Configurazioni → Interfaccia → Tag Engine. Cercare la scala che determinerà l'assegnazione del tag e definire le condizioni di assegnazione dopo aver premuto il tasto +.

Tag	Punteggio minimo	Punteggio massimo	Opzioni

7.7 Abilitare/disabilitare la scansione del braccialetto del paziente

Su NGH andare in Configurazione --> Opzioni avanzate --> Parametri dell'organizzazione.

"Abilita/disabilita lettura barcode paziente in somministrazione" FALSE: non compare mai "braccialetto paziente" né in portale di reparto né in fase di somministrazione.

"Abilita/disabilita lettura barcode paziente in somministrazione" TRUE: se da portale di reparto si scansiona il braccialetto con la pistola, automaticamente entra nella lista attività del paziente scansionato; se si somministra, non richiederà di nuovo il braccialetto paziente. Se invece si va in lista attività del paziente senza passare dalla scansione del braccialetto, in fase di somministrazione come prima cosa si aprirà la schermata di scansione del braccialetto, poi dopo farà selezionare il farmaco.

7.8 Inserimento di valori decimali per un parametro vitale

Su NGH andare in Configurazione → Opzioni → Parametri vitali. Selezionare il parametro vitale di interesse e inserire il valore 1 nel campo "Scala". Viceversa, per rendere un parametro solo a valori interi lasciare vuoto questo campo.

Codice TC		Tipi Ruolo abilitati Aggiungi filtro per Tipo Ruolo	
Descrizione Italiano Temperatura corporea			
Codifica LOINC 8310-5	Posizione 5	Tipo Numero	Range invertito ☐
Precisione	Scala 1	Colore #008193	Unità Misura Default °C
Icona	Visualizza in header terapie ☐	Abilitato per terapie ☒	
Categoria Parametri primari	Sottocategoria Parametri Vitali		

7.9 Modificare l'intervallo temporale di somministrazione terapia

Di default questo è impostato a 4h di ritardo e 2h di anticipo sull'orario previsto da pianificazione. Per cambiarlo, su NGH andare in Configurazione → Opzioni avanzate → Parametri dell'organizzazione. Per modificare le ore di anticipo consentite, modificare i seguenti parametri (e analogamente per le ore di ritardo):

Parametri dell'organizzazione

Opzioni

Interfaccia

Struttura ospedaliera

PDF

FILTRI



Organizzazioni ASST DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO

Visualizza chiavi

Cerca (descrizioni, chiavi, valori)

ore di anticipo

LISTA DI PARAMETRI CHE CONTENGONO: "ORE DI ANTICIP"

FOLDER	Cartella - Attività - Ore di anticipazione esecuzione consentite	ORGANIZATION	4
FOLDER	Cartella - Parametro vitale - Ore di anticipazione esecuzione consentite	ORGANIZATION	4
FOLDER	Cartella - Terapia - Ore di anticipazione esecuzione consentite	ORGANIZATION	4

7.10 Consultazione note di diario importanti in compilazione di LDO

Questa configurazione serve a far comparire le note di diario importanti per la compilazione della LDO in una spalla a destra in fase di compilazione.

In NGH andare in Configurazione → Cataloghi → TagEntry e configurare un tag specifico nel diario: codice LDO, descrizione Importante per LDO, tipo tag Diario, ruoli abilitati Medico e Medico specializzando, colore #008193.

TAGENTRY (TAGENTRY)

Codice

LDO

Ordinamento

Tipo Tag

Diario

Assegnato da tag engine

Descrizione Italiano

Importante per LDO

Colore

#008193

Branca

Aggiungi Specializzazione Medica

Icona

Mostra icona

Tipi Ruolo abilitati

Medico

Medico specializzando

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

VALORI CUSTOM

Elimina

Salva

Disattiva

7.11 Protocollo parametri vitali/attività/schede configurato di default all'ingresso del paziente in reparto

Questa configurazione fa in modo che quando un nuovo paziente viene accettato in reparto, nella sua lista attività si trovi già la programmazione standard per quello specifico reparto per la rilevazione di parametri vitali, compilazione schede, ecc.

In NGH andare in Configurazione → Cataloghi → Protocolli e aggiungere un nuovo protocollo con il tasto +. Assegnargli una descrizione (il codice verrà dato in automatico) e selezionare tipo protocollo: generico, Note “—”. Dai menu Attività, Scheda, Parametri vitali aggiungere le voci desiderate con il relativo tipo di pianificazione e premere salva. Andare poi in Configurazione → Struttura ospedaliera → Reparti e cercare il reparto a cui si vuole associare il protocollo creato. Scorrere in fondo e selezionare il tab Protocolli e premere +. Selezionare il protocollo da associare e cliccare su Aggiungi. Per fare in modo che il protocollo sia inserito in cartella in automatico all’accettazione del paziente, come Azione episodio selezionare Accettazione .

ATTENZIONE: il protocollo va creato e associato al REPARTO (erogatore o duale), non all’area assistenziale associata.

7.12 Aggiunta menu spalla in compilazione LDO

In NGH andare in Configurazione → Utenti e permessi → Ruoli utente. Per il ruolo per cui si vuole abilitare la funzionalità, accendere i diritti: ENCOUNTER_DISCHARGE, ENCOUNTER_DISCHARGE_LETTER_AUTH, FOLDER_SHOW_DOCUMENT_SIDEBAR.

Andare poi in Cataloghi → Tipo di Valutazione e cercare [DISCHARGE_LETTER] Lettera dimissione. Impostare Tipo: Documenti di cartella, Sottocategoria: Lettera di dimissione.

7.13 Correzione decodifica comuni in portale di reparto

Se nel portale di reparto come comune di nascita del paziente non appare il nome del comune ma una dicitura del formato “HL7_XXXXXX” bisogna seguire questa procedura:

Aprire il seguente file presente sul Portale della Fornitura (percorso Documents >> ES 11 – ASST di Crema >> 04_Assessment >> ADT >> Codifiche_confronto.xlsx): [Codifiche_confronto.xlsx](#). Aprire il foglio “Elenco città” e nella colonna B (code) cercare il codice numerico che appare dopo “HL7_” nel portale di reparto. Solo se la codifica è univoca, si può sanare la situazione su NGH in questo modo: andare in Configurazione → Cataloghi → Comune e cercare il codice che appare nel portale di reparto. Selezionare la voce del catalogo e modificare la “Descrizione italiano” da “HL7_XXXXXX” al nome del comune che si è trovato nella colonna C (description) del file excel.

7.14 Aggiungere parametro vitale nel menu a tendina per prescrizione di terapia al bisogno con parametro

In fase di prescrizione di un nuovo farmaco con modalità “al bisogno”, questa si può mettere vincolata ad un parametro vitale configurato in cartella. Di default solo alcuni parametri vitali compaiono nel menu a tendina

dei parametri nella schermata di prescrizione al bisogno. Per fare in modo che un altro parametro vitale configurato in cartella appaia anche in questo menu a tendina, andare in Configurazioni → Opzioni → Parametri vitali. Selezionare il parametro vitale di interesse e accendere il flag “Abilitato per terapie”.

Codice TC		Tipi Ruolo abilitati Aggiungi filtro per Tipo Ruolo	
Descrizione Italiano Temperatura corporea			
Codifica LOINC 8310-5	Posizione 5	Tipo Numero	Range invertito ☐
Precisione 	Scala 	Colore #008193	Unità Misura Default °C
Icona 	Visualizza in header terapie ☐	Abilitato per terapie ☒	
Categoria Parametri primari	Sottocategoria Parametri Vitali 	Visualizza in header episodio ☐	

7.15 Aggiungere protocollo terapeutico

Per aggiungere un protocollo terapeutico selezionabile dal medico in fase di prescrizione, si procede in questo modo: Opzioni → Protocolli terapeutici.

Bisogna creare prima uno o più Modelli di prescrizione. Cliccando su Vai nel sottomenu dei modelli di prescrizione, vi è la lista dei modelli già configurati.

Modelli Prescrizione

Protocolli

CERCA

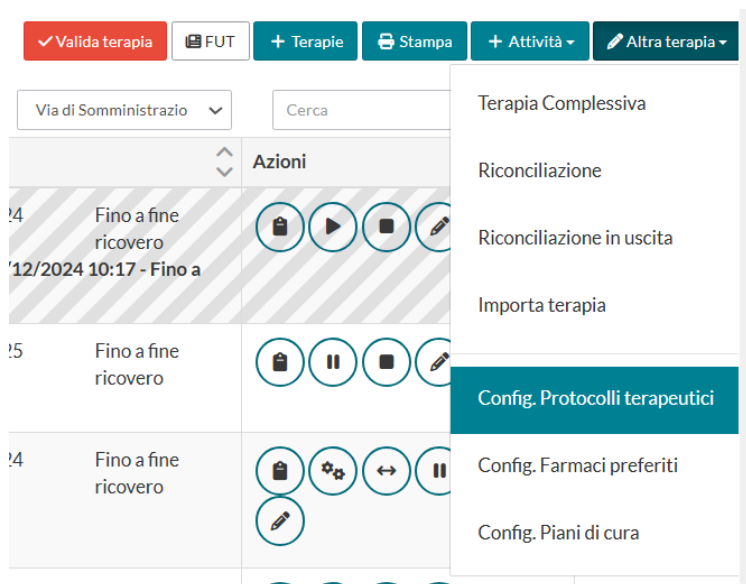
Stato

[PT000029] ACIDO ACETILSALICILICO COMPRESSE GASTRORESISTENTI	i
Orale Ricorrente ☐ v.1	
[PT000032] ACIDO ACETILSALICILICO COMPRESSE GASTRORESISTENTI	i
Orale Ricorrente ☐ v.1	
[PT000020] ACQUA DEPURATA SOLUZIONE	i
Orale Ricorrente ☐ v.1	
[PT000006] AMOXICILLINA/ACIDO CLAVULANICO SOLUZIONE INIETT POLV SOLV	i
Endovenosa (Preparato) Ricorrente ☐ v.2	
[PT000026] ARIPIRAZOLO SOLUZIONE INIETTABILE	i

Una volta che si hanno i modelli di prescrizione di interesse, cliccando sul sottomenu Protocolli, si possono vedere i protocolli già configurati per ogni reparto, o aggiungerne nuovi, cliccando sul +.

Bisogna compilare i campi richiesti (similmente a come sono configurati gli altri protocolli), in particolare, nei reparti va scelto il reparto a cui serve il protocollo, in Ambito va inserito ricovero. Il codice viene generato in automatico dal sistema. Da Modelli prescrizione, si scelgono i modelli da inserire nel protocollo terapeutico.

La configurazione dei protocolli terapeutici può essere fatta anche direttamente da un profilo Medico, Pianificazione → Altra terapia → Config protocolli terapeutici, nello stesso modo mostrato sopra.



N.B. : il medico può salvare un modello prescrittivo anche mentre esegue una prescrizione, cliccando sul pulsante “Salva modello” in basso.

7.16 Aggiungere/modificare parametri di default in maschera di rilevazione

Per aggiungere o modificare i parametri che si trovano nella maschera di rilevazione parametri di default, andare in Configurazioni → Struttura ospedaliera → Reparti. Cercare il reparto di interesse, nei menu in basso selezionare Parametri, da cui impostare i parametri di default.

Esami	Diagnosi	Operazioni	Parametri Vitali	Attività	Protocolli	Vie di Somministrazione	Preparati	Valori Custom
Context keys	Oggettività	Sintomi	Parametri dell'organizzazione		Turni	Medico assegnabile	Tipi di dieta	Categoria Note
Categoria appuntamento		Motivo di inserimento in lista di attesa ambulatoriale			Primario di reparto		Letti deliberati	Profili Esami
Studio Sperimentale								

+

Tipo parametri di default

Tipo parametri di default

Codice	Categoria	Descrizione	Obbligatorio	Modifica
PAS	Parametri primari	Pressione arteriosa sistolica	☐	
SPO2	Parametri primari	Saturazione	☐	
TC	Parametri primari	Temperatura corporea	☐	
ALVO	Parametri primari	Alvo	☐	

Mostra 5

Prima < 1 2 > Ultima

7.17 [Controllare corretta configurazione di una scala/scheda](#)

Il documento con le schede validate da regione si trova su teams percorso 03 metodologie >> 04 configurazioni >> documentazione config ngh >> NGH_documentazioneFormeStampe_v1r53 (man mano che ne riceviamo uno nuovo mettiamo il file vecchio in old e quello aggiornato a questo percorso, quindi quello che trovate qui è sempre l'ultimo).

- Se la scala che chiede l'ente non è presente qui: indicare all'ente di fare richiesta formale a RL
- Se la scala che chiede l'ente c'è nel documento allora è validata da regione e si può configurare in CCE. Va configurata da due punti. 1) da catalogo scheda inserire la scheda a catalogo con codice e descrizione indicate nel documento di form e stampe (per gli altri flag/parametri di config copiare una scala della stessa categoria). 2) da form e stampe >> gestione form aggiungere anche qui una nuova voce relativa alla scheda appena configurata (come sopra, vedi una scala simile per fare la config, sono praticamente tutte uguali).

7.18 [NGH Continuity System](#)

Link sul Pdf al manuale: [AQ1_ARIA_CCE_Manuale_Configurazione_Continuity_system_v2](#)

Configurazione: Configurazioni >> Opzioni avanzate >> Parametri dell'organizzazione.

Cercare le seguenti chiavi:

BACKUP_CLIENT_TRACKER_WARNING_EMAIL_RECIPIENTS: mettere gli indirizzi email, separate da sole virgole senza nessuno spazio, degli utenti che riceveranno le email di mancata sincronizzazione dei client.

BACKUP_FLD_COMPLETE_WARNING_EMAIL_RECIPIENTS: mettere gli indirizzi email, separati da sole virgole senza nessuno spazio, degli utenti che riceveranno le email di errori nella generazione dei file di backup.

BACKUP_MONITOR_JOB_MAX_FILE_AGE: di default impostato con il valore 120, ma se dovesse comparire un avviso come quello riportato qui di seguito, Giuseppe Salvatore di GPI suggerisce di impostarlo a 180, che è un valore sufficientemente alto visto che il backup mediamente dura 120 minuti.

RIEPILOGO

Numero di file pdf presenti: 93
Età massima consentita da configurazione: 120 minuti
File più recenti di 120 minuti: 93
File più vecchi di 120 minuti: 0
Durata media delle ultime esecuzioni: ~144 minuti
ATTENZIONE: la durata media del job di backup è maggiore all'età massima consentita ai pdf. I pdf non fanno in tempo a generarsi che già sono obsoleti. Impostare il valore del parametro BACKUP_MONITOR_JOB_MAX_FILE_AGE ad un valore superiore a 144.

Come controllare che le stampe di backup vengano generate correttamente da NGH: Configurazioni >> Opzioni avanzate >> Continuità di cartella

Per verificare i dati impostati lato client (menu a tendina):

<https://business-continuity.cce.servizirl.it/version.json>

Se non funziona il sistema di alert controllare che il parametro dell'organizzazione "Tracciamento job di backup cartella: job abilitato" sia impostato a true.

7.19 Aggiungere un'allergia non presente su NGH

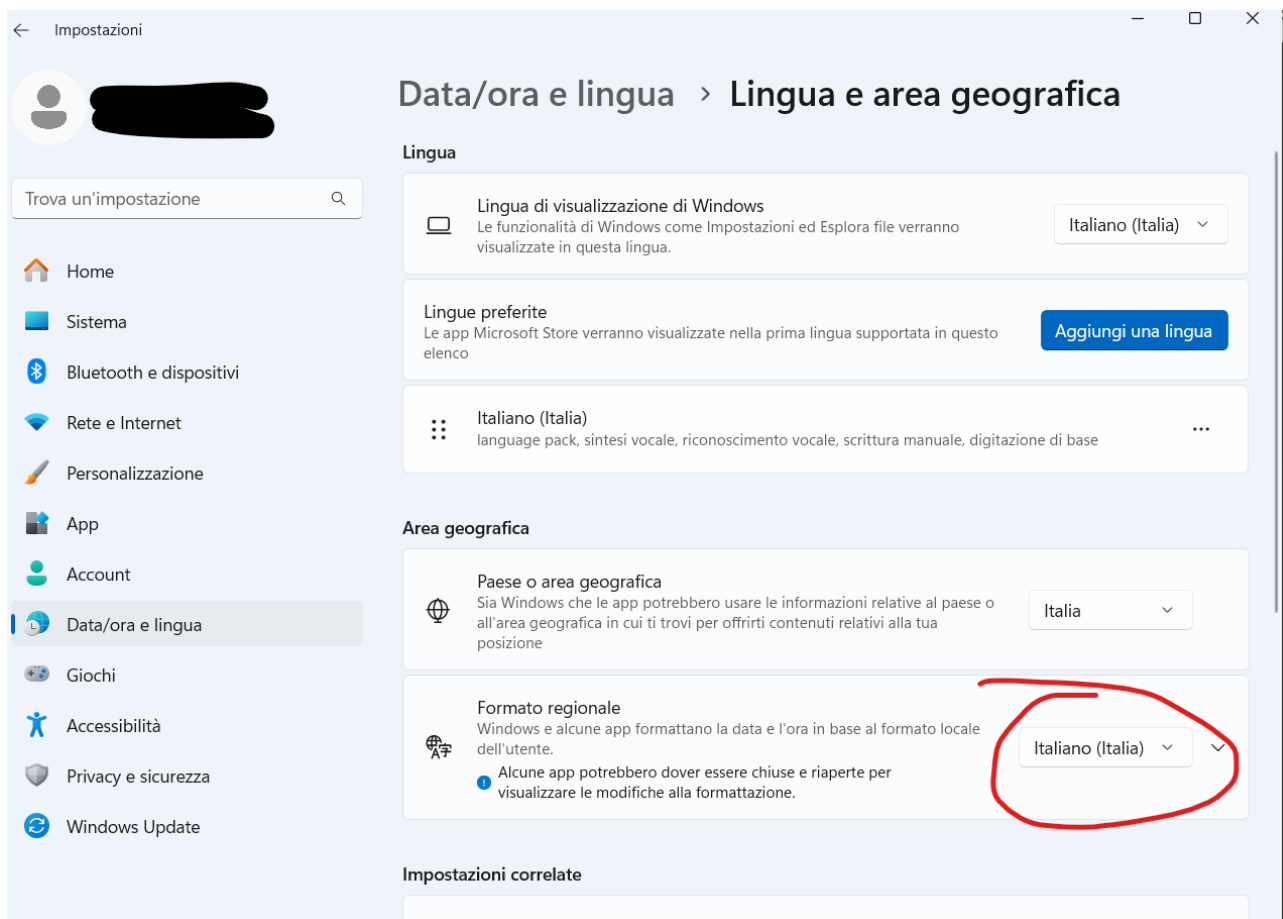
Cercare i codici degli allergeni per comunicare le allergie mediante risorse FHIR. Qui il link al sito FHIR che riporta il valueset degli allergeni: <https://fhir.org/guides/stats2/valueset-ch.fhir.ig.ch-allergyintolerance-challergyintolerancereactionsubstancevalueset.html>

Poi comunicarli a Mascheroni (andrea.mascheroni@gpi.it), perché devono aggiungerli su tutti gli enti con l'apposita codifica LOINC.

7.20 Prescrizione terapia: dosaggio con virgola

Su molti pc non risultava possibile inserire il dosaggio della terapia utilizzando la virgola come separatore decimale. È un problema dovuto a impostazioni di windows che si può risolvere in questo modo:

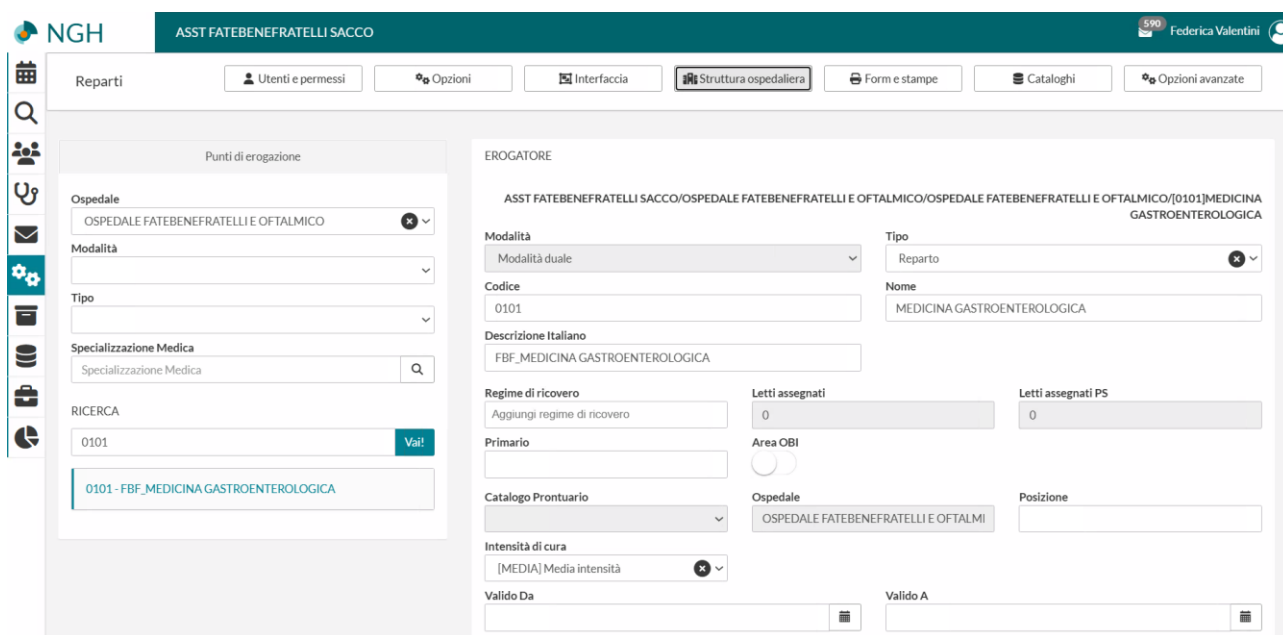
Data/ora lingua -> Lingua e area geografica -> Formato regionale -> Italiano (Italia).



7.21 Richieste esami limitate verso gli erogatori

Mediante questa configurazione si fa in modo che i medici di un reparto possano chiedere prestazioni soltanto ai reparti previsti.

Configurazioni -> Struttura ospedaliera -> Reparti -> Ospedale (scegliere) -> Ricerca (scegliere reparto)



Sotto, in “Richieste esami limitate verso gli erogatori” si inseriscono tutti i reparti, uno per uno e facendo attenzione al codice, verso cui è previsto che il reparto in questione richieda consulenze e prestazioni RIS/LIS/AP.

▼ Aree Assistenziali Di Appoggio

▼ Reparti Clinici Per Ricezione Appoggi

▲ Richieste Esami Limitate Verso Gli Erogatori

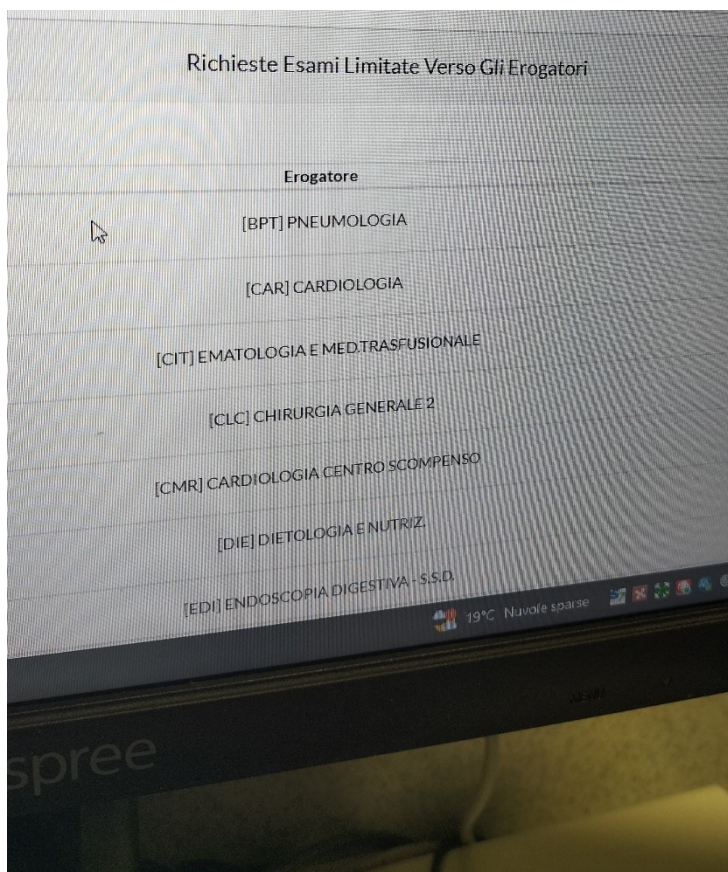
Nessun punto di erogazione configurato

Carica tutto ↺ +

▼ Richieste Esami Prericovero Limitate Verso Gli Erogatori

▼ Richieste Esami Follow Up Limitate Verso Gli Erogatori

Trasferimenti in uscita limitati ai reparti: +



7.22 Tipi di stampe cartella

Qui una breve guida sulle diverse stampe cartella che è possibile generare da NGH: [Guida Stampe CCE.docx](#)

7.23 Abilitare il tasto stampa per la lettera di trasferimento medica

Configurazioni >> Form e stampe >> Gestione form: cercare la lettera di trasferimento medica e spegnere il flag (che nello screen è ancora acceso) di Nascondi tasto stampa. La configurazione varrà per tutte le lettere di trasferimento mediche compilate da nuovo dopo aver salvato la configurazione. Non comparirà quindi il tasto stampa di fianco a lettere di trasferimento mediche già in stato definitivo o di fianco a nuove versioni/duplicati di lettere già compilate.

Gestione form Utenti e permessi Opzioni Interfaccia Struttura ospedaliera Form e stampe Cataloghi Opzioni avanzate

SCHEDA ✕

Reparto +
Nessun dato

Area di degenza
Area di degenza Q

Scheda
[lettera_trasferimento_MED] LETTERA DI TRASFERIMENTO MEDICA ✕

Tipo episodio
Ricovero ✕

Azione
v

Usa obbligatori  sched 
☐ (Non obbligatoria)

Obbligatoria
☐

Sostituibile
☒

Usa ripetibilit  sched 
☒ (Ripetibile)

Ripetibilit 
v

Inline
☐

Nascondi salvataggio in bozza
☐

Nascondi anteprima di Stampa
☒

Anteprima di stampa interna
☐

Nascondi tasto stampa
☒

Posizione

Usa apri stampa in automatico della sched 
☐ (No)

Apri stampa in automatico
☐

Stampa con Calamaio
☐

Modifica sched  ✎ Elimina ✕ Salva S

7.24 Indice XML

In fase di chiusura di una cartella   possibile generare e stampare l'indice XML della cartella, documento che viene prodotto dalla CCE e contiene le referenziazioni logiche e i metadati minimi dei documenti gi  firmati e archiviati nel repository aziendale dalla CCE in riferimento all'episodio di cura.

L'indice XML, che   stato sviluppato su cartella per direttive regionali, dovrebbe essere firmato e archiviato per ciascuna cartella chiusa. Ciononostante, sta all'Ente stabilire come e quando partire con la firma e l'archiviazione degli indici, quindi occorre valutare con le direzioni mediche l'operativit  da adottare. Per mandare in stampa l'indice XML si procede come per la chiusura cartella, cliccando il menu a tendina di fianco alla stampante in alto a destra e selezionando 'Indice XML di cartella', che si abilita una volta che la cartella   in stato 'Chiusa'.

Pu  succedere che nel tab 'dimessi' venga visualizzato l'alert 'indice xml non firmato' nella colonna dello stato della cartella, e questo genera segnalazioni da parte degli utenti. Nell'immagine sottostante vediamo come fare per togliere la generazione dell'alert tramite configurazione (previa approvazione dalla direzione).

TIPO DOCUMENTO REPOSITORY (REPOSITORYDOCUMENTTYPE) ✕

Codice
FLD_FINAL

Ordinamento
v

Descrizione Italiano
Stampa cartella definitiva

Descrizione Inglese
Folder final print

Tipi Ruolo abilitati
Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo documento
Cartella ✕

Con il flag abilitato si attiva il controllo sulla presenza dell'indice xml nella tab dimessi
Indice XML i
☒

Invia al SISS
☐

Stampa diretta
☐

Allega in cartella
☐

Invia al repository
☒

Stampa cartella definitiva i
☒

METADATI +

In caso di dubbi la direzione pu  interfacciarsi con la Regione.

7.25 Import documenti in CCE con riferimento al nosologico

Per importare in CCE un documento firmato e pubblicato sul repository per un determinato nosologico (esempio: verbale chirurgico) bisogna configurare nel catalogo Tipo documento repository, per la voce VOP – Verbale operatorio, il valore custom NGH_MDM^SACCO con il valore 97 (come riportato nel TXA.2 del MDM^T01).

8 Partogramma

Riferimenti ai manuali di configurazione NGH (si trovano su Teams, percorso: 04. Configurazioni NGH, Documentazione configurazioni NGH, Note configurative)

- Paragrafo 1.12 delle note di rilascio configurative della v. 8.3 di NGH
- Paragrafo 1.12 delle note di rilascio configurative della v. 8.7_b10 di NGH

8.1 Attivazione diritti

Configurazioni >> Utenti e permessi >> Ruoli utente >> cercare nella barra di ricerca sulla sinistra i ruoli per cui si vogliono attivare i diritti: per il ruolo Admin NGH e per il ruolo Ostetrico attivare i diritti che contengono la parola chiave Partogramma:

Categoria	Codice	Stato	Descrizione
DIRITTI MODULI CARTELLA	Modulo Partogramma		Modulo Partogramma
PARTOGRAMMA	Grafico: modifica abilitata		Grafico: modifica abilitata
PARTOGRAMMA	Partogramma : riapertura		Partogramma : riapertura abilitata
PARTOGRAMMA	Schede: modifica abilitata		Schede: modifica abilitata

8.2 Catalogo: categoria partogramma

Configurazioni >> Cataloghi >> Categoria partogramma. Tradurre la descrizione delle voci come segue (quindi ad esempio come descrizione della voce a catalogo con codice GRAPHIC mettere Grafico di partogramma):

GRAPHIC: Grafico di partogramma

CARE_SUPPORT: Supporto alle cure

PROGRESSION_OF_LABOR: Progressione del travaglio

MONITORING_OF_FETAL_WELL_BEING: Sorveglianza del benessere fetale

MONITORING_OF_MATERNAL_WELL_BEING: Sorveglianza del benessere materno

PHARMACOTHERAPY: Farmacoterapia

CARE_PLAN: Piano assistenziale

INFO_PANEL: Specchietto informativo

8.3 Parametri vitali

Configurazioni >> Opzioni >> Parametri vitali. Configurare i parametri vitali con codice Dilatazione e Parte_presentata come riportato negli screen di seguito:

DETTAGLI

Codice Dilatazione		Tipi Ruolo abilitati Aggiungi filtro per Tipo Ruolo	
Descrizione Italiano Dilatazione cervicale			
Codifica LOINC 11784-6	Posizione 0	Tipo Numero	
Precisione 2	Scala 0	Colore #1f77b4	Unità Misura Default cm
Icona 	Visualizza in header terapie ☐	Abilitato per terapie ☐	
Categoria Parametri primari	Sottocategoria Parametri Vitali 	Categoria Partogramma Grafico Partogramma	Visualizza in header episodio ☐
Range di validità 		System URL (FHIR) 	
Trasfusionale: parametro in checklist 			

DETTAGLI

Codice Parte_presentata		Tipi Ruolo abilitati Aggiungi filtro per Tipo Ruolo	
Descrizione Italiano Parte Presentata			
Codifica LOINC 	Posizione 0	Tipo Numero	
Precisione 2	Scala 0	Colore #ff7f0e	Unità Misura Default
Icona 	Visualizza in header terapie ☐	Abilitato per terapie ☐	
Categoria Parametri primari	Sottocategoria Parametri Vitali 	Categoria Partogramma Grafico Partogramma	Visualizza in header episodio ☐
Range di validità 		System URL (FHIR) 	
Trasfusionale: parametro in checklist 			

Affinché vengano rappresentati correttamente sul grafico è necessario successivamente popolare

due parametri dell'organizzazione (Opzioni avanzate >> parametri dell'organizzazione) utilizzando il codice del parametro corrispondente.

- [FOLDER] Partogramma: codice parametro vitale 1
- [FOLDER] Partogramma: codice parametro vitale 2

LISTA DI PARAMETRI CHE CONTENGONO: "PARTOGR"			
FOLDER	Partogramma: codice parametro vitale 1	ORGANIZATION	Dilatazione
FOLDER	Partogramma: codice parametro vitale 2	ORGANIZATION	Parte_presentata

8.4 Catalogo: eventi cartella

Configurazioni >> Cataloghi >> Eventi cartella. Configurare i seguenti eventi cartella:

EVENTI CARTELLA (FOLDEREVENT) ✕

Codice

1STADIO

Ordinamento

0

Descrizione Italiano

Primo stadio - Fase attiva

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo

Partogramma ✕

Evidenzia evento

☒

Seleziona colore intervallo evento

#F7C6C6

VALORI CUSTOM

+

Elimina 🗑

Salva 💾

Disattiva 🔇

Nota: invertire secondo stadio fase attiva e passiva. Quindi fase passiva ha ordinamento 2 e colore #FD9D9D, mentre fase attiva ha ordinamento 3 e colore #FF8080.

EVENTI CARTELLA (FOLDEREVENT) ✕

Codice

2STADIO_A

Ordinamento

2

Descrizione Italiano

Secondo stadio - Fase attiva

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo

Partogramma ✕

Evidenzia evento

☒

Seleziona colore intervallo evento

#FD9D9D

VALORI CUSTOM

+

Elimina 🗑

Salva 💾

Disattiva 🔇

EVENTI CARTELLA (FOLDEREVENT)



Codice

2STADIO_P

Ordinamento

3

Descrizione Italiano

Secondo stadio - Fase passiva

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo

Partogramma



Evidenzia evento



Seleziona colore intervallo evento



#FF8080

VALORI CUSTOM



Elimina



Salva



Disattiva



EVENTI CARTELLA (FOLDEREVENT)



Codice

PRT_PARTO

Ordinamento

4

Descrizione Italiano

Parto

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo

Partogramma



Evidenzia evento



Seleziona colore intervallo evento



#FF0000

VALORI CUSTOM



Elimina



Salva



Disattiva



Se ci sono altri eventi cartella con Tipo: Partogramma, disattivarli con il tasto Disattiva in basso a destra (dovrebbe essere da disabilitare solo la voce "Periodo espulsivo").

N.B.: NON disattivare gli eventi che hanno Tipo diverso da Partogramma (esempio: non disattivare l'evento Inizio preparazione intervento).

8.5 Catalogo: dati entità cliniche

Configurazioni >> Cataloghi >> dati entità cliniche. Configurare le seguenti voci a catalogo:

1. ACCELERAZIONI Accelerazioni (TESTO)
2. DEC Decelerazioni (TESTO)
3. FC_FETALE Frequenza cardiaca fetale di base (NUMERO)
4. INDICE_PT Indice posizione (TESTO)
5. NUMERO // (NUMERO)
6. TESTO Campo testo (Testo)
7. VAR Variabilità (Testo)

DATI ENTITÀ CLINICHE (CLINICAENTITYDATA)



Codice

ACCELERAZIONI

Ordinamento

Descrizione Italiano

Accelerazioni

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo

Testo



VALORI CUSTOM



Elimina 

Salva 

Disattiva 

DATI ENTITÀ CLINICHE (CLINICAENTITYDATA)



Codice

DEC

Ordinamento

Descrizione Italiano

Decelerazioni

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo

Testo



VALORI CUSTOM



Elimina 

Salva 

Disattiva 

DATI ENTITÀ CLINICHE (CLINICAENTITYDATA)



Codice

FC_FETALE

Ordinamento

Descrizione Italiano

Frequenza cardiaca fetale di base

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo

Numero



VALORI CUSTOM



Elimina 

Salva 

Disattiva 

DATI ENTITÀ CLINICHE (CLINICAENTITYDATA)



Codice

INDICE_PT

Ordinamento

Descrizione Italiano

Indice posizione

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo

Testo



VALORI CUSTOM



Elimina 

Salva 

Disattiva 

DATI ENTITÀ CLINICHE (CLINICAENTITYDATA)



Codice

NUMERO

Ordinamento

Descrizione Italiano

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo

Numero



VALORI CUSTOM



Elimina

Salva

Disattiva

DATI ENTITÀ CLINICHE (CLINICAENTITYDATA)



Codice

TESTO

Ordinamento

Descrizione Italiano

Campo testo

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo

Testo



VALORI CUSTOM



Elimina

Salva

Disattiva

DATI ENTITÀ CLINICHE (CLINICAENTITYDATA)



Codice

VAR

Ordinamento

Descrizione Italiano

Variabilità

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo

Testo



VALORI CUSTOM



Elimina

Salva

Disattiva

8.6 Catalogo: valori entità cliniche

Configurazioni >> Cataloghi >> Valori entità cliniche. Configurare le voci a catalogo così come già configurate in ambiente di prod di ASST Pavia (se non si ha accesso chiedere a qualcuno che ha l'accesso di profilarvi).

8.7 Catalogo: entità cliniche

Configurazioni >> Cataloghi >> Entità cliniche. Configurare le voci a catalogo così come già configurate in ambiente di prod di ASST Pavia (se non si ha accesso chiedere a qualcuno che ha l'accesso di profilarvi).

NOTA: è sbagliato CTC, la voce corretta è CTG >> correggere.

Specchietto informativo:

Per le entità cliniche definite con categoria “Specchietto informativo” è necessario configurare i campi “Codice EasyForm” e “Codice Riassunto”.

Il Codice Easyform deve essere valorizzato con il codice di riferimento della scheda Easyform all'interno del quale l'utente compila il dato che viene poi riportato nello specchietto informativo.

Il codice Riassunto deve essere valorizzato con il nome del Riassunto definito all'interno della scheda Easyform.

I valori da riportare sono i seguenti :

➤ Entità Clinica **Tampone GBS**:

o Codice Easyform = Anamnesi_OST_GEN;

o Codice Riassunto = Esito Tampone;

➤ Entità Clinica **Parità**:

o Codice Easyform = Anamnesi_OST_GEN;

o Codice Riassunto = Parità;

➤ Entità Clinica **PROM**:

o Codice Easyform = Anamnesi_Prossima_OST_GINE;

o Codice Riassunto = Prom;

➤ Entità Clinica **Check Intrapartum BRO**:

o Codice Easyform = Anamnesi_Prossima_OST_GINE;

o Codice Riassunto = Check Intrapartum;

8.8 Configurazione schede parto, terzo stadio, quarto stadio

STEP 0:

Verificare che la configurazione non sia già stata fatta da GPI in fase di caricamento delle schede in ambiente. Se non è stato fatto, seguire gli step sotto.

STEP 1:

Configurazioni >> Cataloghi >> Tipo di valutazione: creare le seguenti voci: Nascita, Partogramma, Grafico partogramma, come di seguito indicato:

TIPO DI VALUTAZIONE (ASSESSMENTTYPE)

Codice BIRTH	Ordinamento 			
Descrizione Italiano Nascita				
Tipi Ruolo abilitati Aggiungi filtro per Tipo Ruolo	Tipo Cartella	Sottocategoria Nascita	Tipologia Episodio	
Attiva slider schede di reparto ☒				
VALORI CUSTOM				
				+ Elimina Salva Disattiva

TIPO DI VALUTAZIONE (ASSESSMENTTYPE)

Codice PARTOGRAMMA	Ordinamento 			
Descrizione Italiano Partogramma				
Tipi Ruolo abilitati Aggiungi filtro per Tipo Ruolo	Tipo Cartella	Sottocategoria Partogramma	Tipologia Episodio	
Attiva slider schede di reparto ☐				
VALORI CUSTOM				
				+ Elimina Salva Disattiva

TIPO DI VALUTAZIONE (ASSESSMENTTYPE)

Codice GRAFICO PARTOGRAMMA	Ordinamento 			
Descrizione Italiano Grafico partogramma				
Tipi Ruolo abilitati Aggiungi filtro per Tipo Ruolo	Tipo Cartella	Sottocategoria Grafico Partogramma	Tipologia Episodio	
Attiva slider schede di reparto ☐				
VALORI CUSTOM				
				+ Elimina Salva Disattiva

STEP 2:

Configurazioni >> Cataloghi >> Scheda: configurare le tre schede (parto, terzo stadio, quarto stadio), come di seguito (aggiungere le voci a catalogo):

SCHEDA (FORM)

Codice

PRT_SCDPARTO

Tipologia Scheda

FOLDER

Ordinamento

1

Valutazione

[BIRTH]Nascita

Anamnesi

☐

Tipo Anamnesi

anamnesis_anamnesisType

Codice prospetto Easyform

Descrizione Italiano

Scheda Parto

Versione

1

Obbligatorio

☐

Ripetibile

Ripetibile

Validabile

☐

Apri stampa in automatico

☐

Abilita selezione lingua di stampa

☐

Pianificabile

☒

Clona ultima compilazione

☒

Instanziabile

☒

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Espressione regolare

Minimo

Massimo

Versione Form Manager

FM3

Parametro vitale

Parametri Vitali

Scheda parto: Accendere tutti i flag di “informazioni da caricare nell’initdata”, tranne l’ultimo (carica motivazioni deve rimanere spento).

SCHEDA (FORM)

Codice

PRT_TERZOSTADIO

Tipologia Scheda

FOLDER

Ordinamento

2

Valutazione

[BIRTH]Nascita

Anamnesi

☐

Tipo Anamnesi

anamnesis_anamnesisType

Codice prospetto Easyform

Descrizione Italiano

Terzo Stadio

Versione

1

Obbligatorio

☐

Ripetibile

Ripetibile

Validabile

☐

Apri stampa in automatico

☐

Abilita selezione lingua di stampa

☐

Pianificabile

☒

Clona ultima compilazione

☒

Instanziabile

☒

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Espressione regolare

Minimo

Massimo

Versione Form Manager

FM3

Parametro vitale

Parametri Vitali

Terzo stadio: Accendere tutti i flag di “informazioni da caricare nell’initdata”, tranne l’ultimo (carica motivazioni deve rimanere spento).

SCHEDA (FORM)



Codice PRT_QUARTOSTADIO		Tipologia Scheda FOLDER		Ordinamento 3	
Valutazione [BIRTH]Nascita		Anamnesi		Tipo Anamnesi anamnesis_anamnesisType	
Codice prospetto Easyform					
Descrizione Italiano Quarto Stadio					
Versione 1	Obbligatorio ☐	Ripetibile Ripetibile	Validabile ☐	Apri stampa in automatico ☐	Abilita selezione lingua di stampa ☐
Pianificabile ☒	Clona ultima compilazione ☐		Istanziabile ☒		
Tipi Ruolo abilitati Aggiungi filtro per Tipo Ruolo			Espressione regolare		Minimo Massimo
Versione Form Manager FM3	Parametro vitale Parametri Vitali				

Quarto stadio: Lasciare spenti tutti i flag di “informazioni da caricare nell’initdata”

N.B: come “Valutazione” in tutte e tre le schede si può iniziare a mettere Nascita (permette di importare le schede nella CCE del neonato dalla CCE della madre), come indicato negli screenshot sopra. Ogni Ente può scegliere per quale/i delle tre schede vuole abilitare questa funzione (configurazione modificabile in ogni momento, quindi di default abilitiamo questa funzionalità per tutte e tre le schede).

STEP 3:

Configurazioni >> Form e stampe >> Gestione form. Configurare le tre schede appena configurate nel catalogo Scheda come segue:

SCHEDA



Reparto Nessun dato		Area di degenza	
Scheda [PRT_SCDPARTO] Scheda Parto		Tipologia Scheda Cartella	
Tipo episodio		Scopo Form	
Azione			
Usa obbligatorieta scheda ☐ (Non obbligatoria)	Obbligatoria ☐	Sostituibile ☒	Usa ripetibilita scheda ☐ (Ripetibile)
Online ☐	Nascondi salvataggio in bozza ☐	Nascondi anteprima di Stampa ☐	Ripetibilita Ripetibile
Anteprima di stampa interna ☐	Nascondi tasto stampa ☐	Posizione	
Usa apri stampa in automatico della scheda ☐ (No)	Apri stampa in automatico ☐	Stampa con Calamaio ☐	
Modifica scheda Elimina Salva			

SCHEDA

Reparto +
Nessun dato

Area di degenza

Scheda
[PRT_TERZOSTADIO] Terzo Stadio

Tipologia Scheda
Cartella

Tipo episodio

Scopo Form

Azione

Usa obbligatorieta scheda
☐ (Non obbligatoria)

Obbligatoria
☐

Sostituibile
☒

Usa ripetibilita scheda
☐ (Ripetibile)

Ripetibilita

☐ Inline

☐ Nascondi salvataggio in bozza

☐ Nascondi anteprima di Stampa

☐ Anteprima di stampa interna

☐ Nascondi tasto stampa

Posizione

☐ Usa apri stampa in automatico della scheda

☐ Apri stampa in automatico

☐ Stampa con Calamaio

☐ (No)

Modifica scheda

Elimina

Salva

SCHEDA

Reparto +
Nessun dato

Area di degenza

Scheda
[PRT_QUARTOSTADIO] Quarto Stadio

Tipologia Scheda
Cartella

Tipo episodio

Scopo Form

Azione

Usa obbligatorieta scheda
☐ (Non obbligatoria)

Obbligatoria
☐

Sostituibile
☒

Usa ripetibilita scheda
☐ (Ripetibile)

Ripetibilita

☐ Inline

☐ Nascondi salvataggio in bozza

☐ Nascondi anteprima di Stampa

☐ Anteprima di stampa interna

☐ Nascondi tasto stampa

Posizione

☐ Usa apri stampa in automatico della scheda

☐ Apri stampa in automatico

☐ Stampa con Calamaio

☐ (No)

Modifica scheda

Elimina

Salva

8.9 Configurazione anamnesi ostetrico-ginecologica

STEP 1:

Configurazioni >> Cataloghi >> Tipo anamnesi. Aggiungere le seguenti voci a catalogo ([CODICE] Descrizione):

[FAMILIAR_OG] Familiare Ostetrico Ginecologica, ordinamento = 1

[FISIO_OG] Fisiologica Ostetrico Ginecologica, ordinamento = 2

[SOC_OG] Sociale Ostetrico Ginecologica, ordinamento = 3

[REM_OG] Remota Ostetrico Ginecologica, ordinamento = 4

[PROS_OG] Prossima Ostetrico Ginecologica, ordinamento = 5

[ANA_OG] Ostetrico Ginecologica, ordinamento = 6

STEP 2:

Configurazioni >> Cataloghi >> Template anamnesi. Aggiungere la seguente voce:

Codice: OST_GINE

Descrizione: Anamnesi Ostetrica Ginecologica

Specializzazioni mediche: 37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Tipo anamnesi: aggiungere le 6 anamnesi configurate nello step 1.

STEP 3:

Configurazioni >> Cataloghi >> Scheda. Configurare le schede per le stesse 6 anamnesi come segue (tutti i flag che non sono inclusi nello screen sono da lasciare spenti):

N.B.: negli screen non è popolato il campo "Ordinamento", ma popolarlo come segue:

Anamnesi familiare: ordinamento = 1

Anamnesi fisiologica: ordinamento = 2

Anamnesi sociale: ordinamento = 3

Anamnesi patologica remota: ordinamento = 4

Anamnesi patologica prossima: ordinamento = 5

Anamnesi ostetrico ginecologica: ordinamento = 6

SCHEDA (FORM) ✕

Codice Anamensi_Familiare_OST_GINE		Tipologia Scheda FOLDER		Ordinamento	
Valutazione		Anamnesi ☒		Tipo Anamnesi [FAMILIAR_OG] Familiare Ostetrico Ginecologica	
Codice prospetto Easyform					
Descrizione Italiano Anamnesi Familiare Ostetrico Ginecologica					
Versione 1	Obbligatorio ☐	Ripetibile Ripetibile	Validabile ☐	Apri stampa in automatico ☐	Abilita selezione lingua di stampa ☐
Pianificabile ☒	Clona ultima compilazione ☐		Istanziabile ☒		
Tipi Ruolo abilitati Aggiungi filtro per Tipo Ruolo			Espressione regolare		
Versione Form Manager EF			Parametro vitale Parametri Vitali		
			Minimo		
			Massimo		

SCHEDA (FORM)



Codice Anamensi_Sociale_OST_GINE	Tipologia Scheda FOLDER	Ordinamento
Valutazione	Anamnesi ☒	Tipo Anamnesi [SOC_OG] Sociale Ostetrico Ginecologica
Codice prospetto Easyform		
Descrizione Italiano Anamnesi Sociale Ostetrico Ginecologica		
Versione 1	Obbligatorio ☐	Ripetibile Ripetibile
Pianificabile ☒	Validabile ☐	Apri stampa in automatico ☐
	Clona ultima compilazione ☐	Abilita selezione lingua di stampa ☒
Tipi Ruolo abilitati Aggiungi filtro per Tipo Ruolo	Espressione regolare	Minimo Massimo
Versione Form Manager EF	Parametro vitale Parametri Vitali	

SCHEDA (FORM)



Codice Anamensi_Fisiologica_OST_GINE	Tipologia Scheda FOLDER	Ordinamento
Valutazione	Anamnesi ☒	Tipo Anamnesi [FISIO_OG] Fisiologica Ostetrico Ginecologica
Codice prospetto Easyform		
Descrizione Italiano Anamnesi Fisiologica Ostetrico Ginecologica		
Versione 1	Obbligatorio ☐	Ripetibile Ripetibile
Pianificabile ☒	Validabile ☐	Apri stampa in automatico ☐
	Clona ultima compilazione ☐	Abilita selezione lingua di stampa ☒
Tipi Ruolo abilitati Aggiungi filtro per Tipo Ruolo	Espressione regolare	Minimo Massimo
Versione Form Manager EF	Parametro vitale Parametri Vitali	

SCHEDA (FORM)



Codice Anamensi_OST_GEN	Tipologia Scheda FOLDER	Ordinamento
Valutazione	Anamnesi ☐	Tipo Anamnesi [ANA_OG] Ostetrico Ginecologica
Codice prospetto Easyform Riassunto 1		
Descrizione Italiano Anamnesi Ostetrico Ginecologica		
Versione 1	Obbligatorio ☐	Ripetibile Ripetibile
Pianificabile ☒	Validabile ☐	Apri stampa in automatico ☐
	Clona ultima compilazione ☐	Abilita selezione lingua di stampa ☒
Tipi Ruolo abilitati Aggiungi filtro per Tipo Ruolo	Espressione regolare	Minimo Massimo
Versione Form Manager EF	Parametro vitale Parametri Vitali	

SCHEDA (FORM) ✕

Codice: Anamnesi_Prossima_OST_GINE

Valutazione: ▼

Codice prospetto Easyform:

Descrizione Italiano: Anamnesi Prossima Ostetrico Ginecologica

Versione: 1

Obbligatorio: ☐

Ripetibile: ▼ Ripetibile

Validabile: ☐

Apri stampa in automatico: ☐

Abilita selezione lingua di stampa: ☐

Pianificabile: ☒

Clona ultima compilazione: ☐

Instanziabile: ☒

Tipi Ruolo abilitati: Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Espressione regolare:

Minimo:

Massimo:

Versione Form Manager: EF ✕ ▼

Parametro vitale: Parametri Vitali Q

Tipologia Scheda: FOLDER ▼

Ordinamento:

Anamnesi: ☒

Tipo Anamnesi: [PROS_OG] Prossima Ostetrico Ginecologica

SCHEDA (FORM) ✕

Codice: Anamnesi_Remote_OST_GINE

Valutazione: ▼

Codice prospetto Easyform:

Descrizione Italiano: Anamnesi Remota Ostetrico Ginecologica

Versione: 1

Obbligatorio: ☐

Ripetibile: ▼ Ripetibile

Validabile: ☐

Apri stampa in automatico: ☐

Abilita selezione lingua di stampa: ☐

Pianificabile: ☐

Clona ultima compilazione: ☐

Instanziabile: ☒

Tipi Ruolo abilitati: Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Espressione regolare:

Minimo:

Massimo:

Versione Form Manager: EF ✕ ▼

Parametro vitale: Parametri Vitali Q

Tipologia Scheda: FOLDER ▼

Ordinamento:

Anamnesi: ☒

Tipo Anamnesi: [REM_OG] Remota Ostetrico Ginecologica

STEP 4:

Configurazioni >> Form e stampe >> Gestione form: configurare le 6 anamnesi appena configurate nel catalogo Scheda come segue:

SCHEDA ✕

Reparto: + Nessun dato

Area di degenza: ▼

Scheda: [Anamnesi_Prossima_OST_GINE] Anamnesi Prossima Ostetrico Ginecologica ✕

Tipologia Scheda: Cartella ▼

Scopo Form: ▼

Tipo episodio: ▼

Azione: ▼

Usa obbligatorieta scheda: ☐ (Non obbligatoria)

Obbligatoria: ☐

Sostituibile: ☐

Usa ripetibilita scheda: ☐ (Ripetibile)

Ripetibilita: ▼

Inline: ☒

Nascondi salvataggio in bozza: ☐

Posizione:

Usa apri stampa in automatico della scheda: ☐ (No)

Apri stampa in automatico: ☐

Stampa con Calamaio: ☐

Modifica scheda ✎ | Elimina ✖ | Salva 💾

SCHEDA



Reparto
Nessun dato

Area di degenza

Scheda

[Anamensi_Familiare_OST_GINE] Anamnesi Familiare Ostetrico Ginecologica



Tipologia Scheda

Cartella

Scopo Form

Tipo episodio

Azione

Usa obbligatorieta scheda
☐ (Non obbligatoria)

Obbligatoria
☐

Sostituibile
☐

Usa ripetibilita scheda
☐ (Ripetibile)

Ripetibilita

Inline
☒

Nascondi salvataggio in bozza
☐

Posizione

Usa apri stampa in automatico della scheda
☐ (No)

Apri stampa in automatico
☐

Stampa con Calamaio
☐

Modifica scheda Elimina Salva

SCHEDA



Reparto
Nessun dato

Area di degenza

Scheda

[Anamensi_OST_GEN] Anamnesi Ostetrico Ginecologica



Tipologia Scheda

Cartella

Scopo Form

Tipo episodio

Azione

Usa obbligatorieta scheda
☐ (Non obbligatoria)

Obbligatoria
☐

Sostituibile
☐

Usa ripetibilita scheda
☐ (Ripetibile)

Ripetibilita

Inline
☒

Nascondi salvataggio in bozza
☐

Posizione

Usa apri stampa in automatico della scheda
☐ (No)

Apri stampa in automatico
☐

Stampa con Calamaio
☐

Modifica scheda Elimina Salva

SCHEDA



Reparto
Nessun dato

Area di degenza

Scheda

[Anamensi_Sociale_OST_GINE] Anamnesi Sociale Ostetrico Ginecologica



Tipologia Scheda

Cartella

Scopo Form

Tipo episodio

Azione

Usa obbligatorieta scheda
☐ (Non obbligatoria)

Obbligatoria
☐

Sostituibile
☐

Usa ripetibilita scheda
☐ (Ripetibile)

Ripetibilita

Inline
☒

Nascondi salvataggio in bozza
☐

Posizione

Usa apri stampa in automatico della scheda
☐ (No)

Apri stampa in automatico
☐

Stampa con Calamaio
☐

Modifica scheda Elimina Salva

SCHEDA



Reparto
Nessun dato

Area di degenza

Scheda

Tipologia Scheda

Tipo episodio

Scopo Form

Azione

Usa obbligatorieta scheda

☐ (Non obbligatoria)

Obbligatoria

☐

Sostituibile

☐

Usa ripetibilita scheda

☐ (Ripetibile)

Ripetibilita

Inline

☒

Nascondi salvataggio in bozza

☐

Posizione

Usa apri stampa in automatico della scheda

☐ (No)

Apri stampa in automatico

☐

Stampa con Calamaio

☐

Modifica scheda

Elimina

Salva

SCHEDA



Reparto
Nessun dato

Area di degenza

Scheda

Tipologia Scheda

Tipo episodio

Scopo Form

Azione

Usa obbligatorieta scheda

☐ (Non obbligatoria)

Obbligatoria

☐

Sostituibile

☐

Usa ripetibilita scheda

☐ (Ripetibile)

Ripetibilita

Inline

☒

Nascondi salvataggio in bozza

☐

Posizione

Usa apri stampa in automatico della scheda

☐ (No)

Apri stampa in automatico

☐

Stampa con Calamaio

☐

Modifica scheda

Elimina

Salva

8.10 Configurazione esame obiettivo ostetrico-ginecologico

STEP 1:

Configurazioni >> Cataloghi >> Scheda. Configurare la scheda per l'esame obiettivo ostetrico-ginecologico come segue:

Codice: Esame_Obiettivo_OST_GINE

Tipologia scheda: FOLDER

Descrizione italiano: Esame obiettivo Ostetrico Ginecologico

Versione: 1

Ripetibile; Istanziabile: flag ON

Versione form manager: EF

Informazioni da caricare nell'Initdata: accendere tutti i flag tranne l'ultimo.

SCHEDA (FORM) ✕

Codice: Tipologia Scheda: Ordinamento:

Valutazione: Anamnesi: Tipo Anamnesi:

Codice prospetto Easyform:

Descrizione Italiano:

Versione: Obbligatorio: ☐ Ripetibile: Validabile: ☐ Apri stampa in automatico: ☐ Abilita selezione lingua di stampa: ☐

Planificabile: ☐ Instanziabile: ☒

Tipi Ruolo abilitati: Espressione regolare: Minimo: Massimo:

Versione Form Manager: Parametro vitale:

STEP 2:

Configurazioni >> Cataloghi >> Esame obiettivo. Configurare una nuova voce come segue:

Codice: OBJ_GEN_OST

Descrizione italiano: Esame obiettivo Ostetrico Ginecologico

Accendere i flag: escludi valutazione sintomi, escludi valutazione oggettività, escludi Fut

Specializzazioni mediche: 37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Sintomi: //

Oggettività: //

Schede: Esame_Obiettivo_OST_GINE

ESAME OBIETTIVO (EXAMINATIONTEMPLATE) ✕

Codice: Ordinamento:

Descrizione Italiano:

Tipi Ruolo abilitati:

Escludi Fut: ☒ Espandi sezione generale: ☐

Escludi valutazione sintomi: ☒ Escludi valutazione oggettività: ☒

SPECIALIZZAZIONI MEDICHE +

Codice	Descrizione
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA

10 Prima 1 Ultima

SINTOMI		+
Nessun valore configurato		

OGGETTIVITÀ		+
Nessun valore configurato		

SCHEDE		+
Codice	Descrizione	
Esame_Obiettivo_OST_GINE	Esame obiettivo Ostetrico Ginecologico	x

10 ▼

Prima 1 Ultima

STEP 3:

Configurazioni >> Form e stampe >> Gestione form. Configurare una nuova voce come segue:

Scheda: [Esame_Obiettivo_OST_GINE] Esame obiettivo Ostetrico Ginecologico

Tipologia scheda: Cartella

Obbligatoria; Ripetibile.

Inserire in "Reparto" tutti i reparti di ostetricia e ginecologia configurati sull'ASST.

SCHEDA		x
Reparto + Nessun dato		Area di degenza Area di degenza
Scheda [Esame_Obiettivo_OST_GINE] Esame obiettivo Ostetrico Ginecologico		Tipologia Scheda Cartella
Tipo episodio ▼		Scopo Form ▼
Azione ▼		
Usa obbligarietà scheda ☐ (Non obbligatoria)	☒ Obbligatoria	☐ Sostituibile
☒ Usa ripetibilità scheda	☒ Ripetibile	Ripetibilità ▼
Inline ☐	Nascondi salvataggio in bozza ☐	Posizione
☐ Usa apri stampa in automatico della scheda	☐ Apri stampa in automatico	☐ Stampa con Calamaio
☐ (No)		
Modifica scheda		Salva

9 Flusso ambulatoriale

9.1 Configurazione prestazione ambulatoriale

Cataloghi > esame cerco il codice della prestazione. Se la prestazione è già presente controllo il 'tipo esame'. Per il flusso ambulatoriale ci serve avere prestazione di tipo 'erogazione ambulatoriale', quindi se non presente devo aggiungere come nuova prestazione la prestazione in oggetto e il tipo esame = erogazione ambulatoriale.

NB: informarsi sull'eventuale presenza di convenzioni per i codici prestazioni. Esempio: se la prestazione è presente per flussi diversi probabilmente si chiamerà RIS_codice o CUP_codice ecc. Esempio: **ASST FBF SACCO mettere prefisso CUP_ davanti al codice prestazione.**

Per creare la prestazione popolo codice, descrizione italiano, tipo esame = erogazione ambulatoriale, specializzazione, tempo di preparazione, durata, tempo di uscita come per tutte le prestazioni. Flag prestazione richiedibile solo con qta = 1, mostra alert se esame già richiesto all'interno dell'episodio, salva.

NB: per FBF Sacco inserire anche come tipi di ruolo Amministratore, Medico, Medico specializzando.

NB: per FBF Sacco non configurare le associazioni prestazione-erogatore e prestazione-agenda, censire solo la prestazione a catalogo.

9.2 Configurazione erogatore ambulatoriale

Passiamo alla configurazione (se non ancora presente) dell'ambulatorio. Andare in struttura ospedaliera > struttura, posizionarsi sotto il presidio in questione (livello HOSPITAL) e cliccare il + per aggiungere un punto di erogazione.

Popolare i campi modalità = erogatore, tipo = ambulatorio, codice, nome e descrizione italiano, specializzazione medica e tipo di cartella, uguale alla specializzazione medica (IMPORTANTE altrimenti i referti non vengono pubblicati sul fascicolo sanitario). Il flag 'abilita erogazione visite ambulatoriali' si abilita in automatico.

NB: informarsi sull'eventuale presenza di convenzioni per i codici degli ambulatori. A seconda dell'Ente può essere che gli erogatori abbiano un codice di tipo CUP_codice

Nel caso in cui l'Ente che stiamo configurando utilizzi la farmacoterapia di NGH attivare il flag 'abilita terapia' (in modo da avere la possibilità di inserire la terapia anche da questo ambulatorio). In basso nella sezione esami aggiungere l'esame configurato precedentemente.

Nel caso in cui la CCE-A si integri con il CUP (esempio: ASST FBF Sacco) accendere flag "Integrazione HL7".

Una volta salvato l'erogatore, popolare il tab "Context keys" con il canale con il CUP. (esempio per Sacco è CUP_OE^SACCO).

NB: quando si censisce un nuovo erogatore di LP va anche creato il profilo utente relativo e va associato all'utente medico.

9.3 Configurazione agenda

Struttura ospedaliera > agende. Se non è già presente configuro una nuova agenda cliccando il +. Popolo il campo codice, tipo = lasciare vuoto, specializzazione, nome italiano, durata slot = 30 e durata sezione = 30 a meno di altre info.

Per quanto riguarda l'equipe, se l'agenda è associata a un singolo medico, non serve indicare un'equipe ma si popola il campo 'proprietario' con il nome del medico. Inoltre, va disattivato il seguente diritto sul ruolo (che in linea generale è 'medico ambulatoriale'):

Categoria	Codice	Stato	Descrizione
PRENOTAZIONI	Visibilità su tutte le agende	☒	Prenotazione - Abilita la modifica della durata dell'esame e lo spostamento di data/ora dell'appuntamento che si sta prenotando

In questo modo l'utente che ha quel ruolo accedendo all'ambulatorio vede solo i pazienti che hanno una prestazione correlata alla sua agenda personale e/o i pazienti che hanno una prestazione legata ad agende "di equipe".

Non è possibile associare specifici utenti a un'equipe, quindi se non è presente un solo medico selezionare equipe standard (ancora da capire/testare).

Solo se NGH viene utilizzata con funzione di CUP (cioè le prenotazioni si fanno direttamente da NGH), attivo i flag prenotazione, prenot. In giornata, accettazione diretta, esposta a reparto richiedente, altrimenti non servono (**esempio: ASST FBF SACCO**).

Aggiungo nei punti di erogazione l'ambulatorio che ho creato prima, salvo.

In basso in esami aggiungo la prestazione precedentemente configurata. Questa configurazione non è necessaria se le prenotazioni arrivano dal CUP (in quanto arriveranno già coerenti con i vincoli di apertura delle varie agende). **Esempio: ASST FBF SACCO**

Nella sezione fascia oraria posso inserire eventualmente le informazioni su orari e giorni di apertura dell'agenda. Questa configurazione non è necessaria se le prenotazioni arrivano dal CUP (in quanto arriveranno già coerenti con i vincoli di apertura delle varie agende). **Esempio: ASST FBF SACCO**

9.4 Associazione erogatore ambulatoriale – referto ambulatoriale

Configurazioni >> Form e stampe >> Gestione form. Nella barra di ricerca sulla sinistra cercare “referto ambulatoriale specialistico” e cliccare sull'unica voce che appare.

Reparto	Area di degenza	Scheda	Azione	Prestazione				Inline	Posizione
(TEST) TEST - NON RICHIEDERE		REFERTO AMBULATORIALE SPECIALISTICO (V. 1 ENCOUNTER_EVENT)	VISIT			✓	✓		
(AMB_TEST) Ambulatorio test									
(CUP_0315) MED PNEUMO FIS. RESP. (AMB.)									
(CUP_9991) AMMINISTRAZIONE - FBF									
(CUP_2216) CARDIOLOGIA (AMB)									
(CUP_5700) CENTRO REG. PER EPILESSIA -									

Una volta cliccato, si apre la pagina di configurazione del ref_ambulatoriale. Cliccare sul tasto + di fianco alla voce Reparto in alto a sinistra, cercare l'ambulatorio che si vuole associare al referto:

SCHEDA

Reparto +	Elimina
[TEST] TEST - NON RICHIEDERE	
[AMB_TEST] Ambulatorio test	
[CUP_0315] MED PNEUMO FIS. RESP. (AMB.)	
[CUP_9991] AMMINISTRAZIONE - FBF	
[CUP_2216] CARDIOLOGIA (AMB)	
[CUP_5700] CENTRO REG. PER EPILESSIA - NEUROLOGIA PED.	
[CUP_2015] CH. PLASTICA (AMB)	

N.B: gli erogatori ambulatoriali sono quelli con prefisso CUP_ (su ASST FBF Sacco). Selezionare l'erogatore/i e salvare. Una volta aggiunti tutti gli erogatori, scorrere fino in fondo alla pagina del ref_ambulatoriale e cliccare salva.

9.5 Configurazione oscuramento referto ambulatoriale

Per poter selezionare l'oscuramento anche per i referti ambulatoriali come avviene per gli altri referti/lettere di dimissione firmati, andare in Configurazioni -> Cataloghi -> Tipo documento repository -> su VISIT_REPORT attivi il flag "Oscuramento documento obbligatorio".

CATALOGHI

docum

Richiesta di documentazione: utilizzo

Richiesta di documentazione: tipo documento

Tipo di Documento

Tipi di documento d'identità

Tipo documento repository

VOCI DEL CATALOGO

repor

Mostra cancella Q

VISIT_REPORT Referto visita

CONSULT_REPORT Referto consulenza

TIPO DOCUMENTO REPOSITORY (REPOSITORYDOCUMENTTYPE)

Codice VISIT_REPORT Ordinalimento 5

Descrizione Italiano Referto visita

Descrizione Inglese Visit report

Tipi Ruolo abilitati

Aggiungi filtro per Tipo Ruolo

Tipo documento Referto visita

Oscuramento documento obbligatorio ☒ Invia al SISS ☒ Stampa diretta ☐ Allega in cartella ☐ Invia al repository ☒ Stampa cartella definitiva ☐

Indice XML

9.6 Configurazione visita a metropolitana

Per passare dalla visualizzazione a schedoni nello step "Visita" alla visualizzazione a metropolitana delle sezioni in visita, andare in Configurazioni >> Cataloghi >> Tipo esame >> [05] Erogazione ambulatoriale e spegnere il flag "Refertazione visita abilitata".

Quindi:

- Flag “Refertazione visita abilitata” ON: visualizzazione a schedoni;
- Flag “Refertazione visita abilitata” OFF: visualizzazione a metropolitana.

9.7 Configurazione prestazioni aggiuntive

Per fare in modo che una prestazione sia richiedibile come aggiuntiva in visita da CCA, va effettuata l’associazione esame-agenda-erogatore. Gli step da fare sono:

- 1) Cercare a catalogo Esame la prestazione ambulatoriale che deve essere richiesta come aggiuntiva (ha prefisso CUP_ nel codice). Per evitare che la visita ambulatoriale per esterni appaia in OE di ricovero, bisogna togliere da catalogo esame i tipi ruolo Medico e Medico specializzando da quell’esame, lasciando solo Amministratore.
- 2) Cercare da Struttura ospedaliera >> Reparti, l’ambulatorio di interesse (ha prefisso CUP_ nel codice) e associargli l’esame di cui al punto 1).
- 3) Cercare da Struttura ospedaliera >> Agende, l’agenda di interesse (non ha nessun prefisso). Scorrere giù fino al modulo Esami e associare l’esame (già associato all’erogatore ambulatoriale). Non compilare Chiusure e Fascia oraria.

10 Configurazione LIS (ASST FBF Sacco)

10.1 Configurazione di un esame-profilo a catalogo Esame

NB: prima controlla che non sia già presente a catalogo l’esame che stai per configurare.

Configura come l’esame-profilo riportato qui sotto (quindi stesso tipo esame, stessa specializzazione, stessi valori numerici e stesso flag acceso) gli esami che trovi nel foglio “censire a catalogo esame” di questo file che è sul Teams:  [Config LIS Sacco TODO.xlsx](#)

Codice LISP_30801	Ordinamento
Descrizione Italiano Stimolo con hGHRH e Arginina	
Alias prestazione 	
Valido dal 	Valido al
Tipo esame [01] Erogazione base	Specializzazione [00] LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE
Tempo di preparazione 0	Durata 30
Codice regionale 	Codice nazionale
Priorità assegnata Priorità assegnata	Emocomponente
Need serological equivalent ☐	Prescription step enabled ☐
Quesito diagnostico obbligatorio ☐	Quesito diagn. testuale obbligatorio ☐
Materiale obbligatorio ☐	Strumentale ☐
Abilita gricode ☐	Mostra alert se esame già richiesto all'interno dell'episodio ☒
Exam per il risultato iniziale 	
Tempo di uscita 0	Giorni soglia in post-ricovero 30
Procedura riferimento 	
Somministrazione farmaco ☐	Need ambiguous ☐
Prestazione richiedibile solo con qta = 1 ☐	Abilita esito prericovero ☐
Ripetibile ☐	Abilita raccolta consenso ☐
Prenotazione ciclica abilitata ☐	Prenotazione multisessione abilitata ☐
Parte Anatomica obbligatoria ☐	Dati aggiuntivi ☐
Pacchetto di prestazioni ☐	

10.2 Associazione esame-erogatore (+ materiale + priorità)

Considera sia gli esami-profilo che hai appena aggiunto a catalogo nello step 10.1, sia gli esami presenti nel foglio “associare a POMM ordinario”. Cerca in configurazioni >> struttura ospedaliera >> reparti l’erogatore LIS11 con descrizione POMM Ordinario. Scorri in fondo fino al tab Esami. Per ogni esame dei due fogli nel file:

- 1) Controlla che il tuo esame non sia tra quelli già associati all’erogatore POMM ridotto (usando la barra di ricerca che c’è). Se non c’è:
- 2) Tasto +, nel box Esame cerchi il tuo codice esame riportato in colonna ID esame nel file (esempio: LIS4210LP), selezioni, salvi. NB: se non lo trovi, configuralo a catalogo come in step 10.1 e poi ritorna qui.

Esami per erogatore

Categoria

Esame

Codice	Descrizione	Valido dal	Valido fino al	Selezionato
LIS4210LP	LP-Glucosio digiuno-			☒

- 3) Cerca l’esame appena inserito con la barra di ricerca:

Esami	Categoria Esami	Profili Esami	Diagnosi	Operazioni	Parametri Vitali	Attività	Protocolli	Vie di Somministrazione
Preparati	Valori Custom	Context keys	Oggettività	Sintomi	Parametri dell'organizzazione	Turni	Medico assegnabile	
Tipi di dieta	Categoria Note	Categoria appuntamento	Motivo di inserimento in lista di attesa ambulatoriale				Primario di reparto	Letti
Studio Sperimentale	Schede Reparto	Stampanti						



LIS4210LP

Visualizzati 1/163 Elementi

#	Codice	Descrizione	Priorità	Valido dal	Valido fino al	Modifica
	LIS4210LP	LP-Glucosio digiuno-				 

- 4) Clicchi la matitina. Nella tendina Materiale accendi il flag relativo al materiale che nell'excel è indicato in colonna ID materiale (se non è indicato niente non troverai nessun materiale da aggiungere, giusto così per gli esami con codice di tipo P_ che hai configurato allo step1). Nell'esempio dell'esame LIS4210LP, accendi il flag LPFBF.

Esami per erogatore

✕

▼
Parametri

▼
Risorse

▲
Materiali

Nessun materiale visibile 

Codice	Descrizione	Visibile
LP	Liquido Pleurico	
LPFBF	LIQUIDO PLEURICO FBF	

- 5) Nella tendina priorità inserisci la priorità indicata in colonna PRIORITA' dell'excel. Nel tuo caso è sempre Routine-Ordinario. Clicchi Salva.

Esami per erogatore

Dati aggiuntivi

▼

Parametri

▼

Risorse

▼

Materiali

▼

Modalità Di Erogazione

^

Priorità

Q

Codice	Descrizione	
NOT_URGENT	Routine - Ordinario	

Salva

- 6) Se aggiorni la pagina ora l'esame ti apparirà così se lo cerchi nella barra di ricerca del tab Esame associato all'erogatore POMM Ordinario:

Esami

Categoria Esami

Profili Esami

Diagnosi

Operazioni

Parametri Vitali

Attività

Protocolli

Vie di Somministrazione

Preparati

Valori Custom

Context keys

Oggettività

Sintomi

Parametri dell'organizzazione

Turni

Medico assegnabile

Tipi di dieta

Categoria Note

Categoria appuntamento

Motivo di inserimento in lista di attesa ambulatoriale

Primario di reparto

Letti

Studio Sperimentale

Schede Reparto

Stampanti

+

Visualizzati 1/163 Elementi

#	Codice	Descrizione	Priorità	Valido dal	Valido fino al	Modifica
	LIS4210LP	LP-Glucosio digiuno-	Routine - Ordinario			✕

10.3 Configurazione etichette LIS

Per attivare la generazione automatica di etichette all'invio di un ordine verso il LIS, andare in Catalogo >> Tipo di report >> Stampa Etichette LIS: aggiungere tutti gli erogatori di laboratorio.

10.4 Configurazione note in richiesta esame

Inserire la dicitura in "Note Italiano" sopra i tipi di ruoli abilitati:

Note Italiano

Il prelievo va effettuato dal lunedì al mercoledì

Tipi Ruolo abilitati

Medico Medico specializzando Amministratore

E compare nelle info della prestazione quando si richiede:

Codice e descrizione

3470 - DETERMINAZIONE ANTIGENE ASPERGILLARE SIERO (GALATTOMANNANO) i

Dati aggiuntivi

DATI AGGIUNTIVI LIS

Il prelievo va effettuato dal lunedì al mercoledì

11 Supporto remoto ASST FBF Sacco: da sapere

11.1 Applicativi in uso nei diversi presidi e template ticket

ADT:

Presidio FBF e Melloni: ADT Aurora >> per disallineamenti ADT-CCE, dopo aver verificato i messaggi sulla GUI scrivere a assistenza.aurora@asst-fbf-sacco.it (con in copia affiancatori.fbfsacco@accenture.com).
precisazione: CCE avviata al FBF ma non ancora al Melloni.

Presidio Sacco e Buzzi: ADT Galileo >> per disallineamenti ADT-CCE, dopo aver verificato i messaggi sulla GUI scrivere a support@dedalus.eu (con in copia affiancatori.fbfsacco@accenture.com e iso.sacco@asst-fbf-sacco.it).
Precisazione: CCE avviata al Sacco ma non ancora al Buzzi.

Template dei ticket da aprire verso Dedalus è il seguente:

PRIORITA': XXX

- Struttura ospedaliera di riferimento: ASST FBF SACCO, ospedale XXX, reparto YYY
- Prodotto Dedalus: ADT HELIOS/GALILEO
- Dettaglio del problema: XXX
- Contatto telefonico: numero telefono, nostro nome e cognome

CUP CAMELIA (SACCO)

Per segnalazioni di visita non visibile da CCA Sacco, scrivere a SIA FBF sia.fbf@asst-fbf-sacco.it, a SIA sacco sia.sacco@asst-fbf-sacco.it e ad agende.sacco@asst-fbf-sacco.it per chiedere di verificare.

Solo in caso siano necessarie ulteriori verifiche, aggiungere al thread m.neritino@replygroup.com

Nella segnalazione specificare che si tratta di CUP CAMELIA.

CUPRL:

In tutta l'ASST è in uso il CUPRL (ad eccezione del presidio Sacco regime SSN che usa ancora CUP Camelia, vedi sopra). Per prenotazioni non visibili in CCA, scrivere mail a affiancatori.cup@asst-fbf-sacco.it con in copia (lorenzo.losciale@asst-fbf-sacco.it, vania.ferrari@asst-fbf-sacco.it e affiancatori.fbfsacco@accenture.com).

N.B.: al profilo admin non sono associati tutti gli ambulatori configurati in CCA (per motivi di lentezza di NGH), quindi per cercare le visite prenotate nell'ambulatorio X, assegnarsi il profilo "Medico ambulatoriale – ambulatorio X" e accedere in CCA con questo profilo.

Verificare sulla GUI eventuali messaggio di ordine in warning.

Se non si è risolta la problematica, aprire ticket come segue:

Template dei ticket da aprire per prenotazione (o modifica di prenotazione) non visibile in CCA:

Il dottor XY ci segnala che non è visibile in CCA la seguente visita:

paziente: nome paziente

data visita: dd/mm/yyyy ore hh:mm

ambulatorio: codice (se disponibile) e descrizione ambulatorio

prestazione: descrizione prestazione

Potete verificare e in caso farci sapere anche in che data il CUPRL ha inviato la prenotazione a CCA?

RIS:

Presidi FBF e Melloni: RIS Philips.

Presidi Sacco e Buzzi: RIS AGFA.

Le richieste RIS sono attive dai reparti del FBF e Melloni. Per problemi con RIS Philips segnalare a rbrenna@дитеch.it (con in copia affiancatori.fbfsacco@accenture.com) se pensate che sia un problema lato RIS, altrimenti segnalazione al service desk come ogni problema applicativo di NGH.

AP:

AP Pathox in tutta l'ASST. Le richieste AP sono attive da tutti i reparti di tutti i presidi dell'ASST. Per aprire i ticket a Tesi la mail è hd@tesigroup.tech. Nuova referente di progetto TESI: Giorgia Pompamea giorgia.pompamea@tesigroup.tech

LIS:

LIS Dedalus in tutta l'ASST. Integrazione LIS non ancora avviata.

11.2 Problemi comuni per ambulatoriale: duplicazione anagrafiche

Se il SIA FBF segnala che una prestazione non è passata su CCA a causa della duplicazione delle anagrafiche, allegando il messaggio HL7 e l'ACK, bisogna:

Aprire ticket direttamente all'assistenza GPI (con in copia affiancatori.fbfsacco@accenture.com) e telefonare per la presa in carico. Template ticket, da inserire l'ACK ricevuto dall'ente:

Buongiorno,

vi chiedo di sanare la medesima problematica risolta con i ticket H01271771, H01273273, H01276722 e H01277049 anche per i seguenti pazienti, l'ente è Fatebenefratelli Sacco:

```
"MSH|^~\&|HIS|GPI|CUPRL|RL|20251110204706.022+0100||ORG^O20|CRL25000000002807873||2.5
```

```
MSA|AE|CRL25000000002807873
```

```
ERR|||207|E|||Find 2 patients with custom value CNU@000006253885 and key PK\S\PK
```

```
"
```

Vi chiedo gentilmente di sanare le anagrafiche duplicate.

Priorità: URGENTE

Una volta ricevuta la risoluzione del ticket da GPI, riprocessare dalla GUI il messaggio di ordine che ora dovrebbe andare in OK.

12 Estrazione dati da Report manager

Dal 03/02/2026 è disponibile la nuova opzione di download dei report al momento disponibili su Report Manager.

Questa tipologia di progetto 'Extractor' consentirà una gestione più agevole dei dati, eliminando le problematiche legate all'esecuzione di query pesanti e il conseguente timeout.

Per scaricare il report di interesse seguire i seguenti step:

- 1) Selezionare "Immediata" come tipologia di estrazione, "Programmata" non è al momento disponibile.

Tipologia di estrazione

▶ Immediata

🕒 Programmata



Intestazioni colonne
Lunghezza fissa

☒ Si ☐ No
 ☐ Si ☒ No

ESEGUI

- 2) Una volta eseguita la query, cliccare sull'ultimo record generato.

Elenco Estrazioni

☒ NUOVA
 ☒ IN_LAVORAZIONE
 ☒ PROGRAMMATA
 ☒ CONCLUSA
☐ SCARICATA
 ☐ ELIMINATA
 ☐ IN_ERRORE

ID	Data Inserimento	Data Esecuzione	
1322	2-feb-2026 17.26.39	IMMEDIATA	 
1162	29-gen-2026 15.41.26	IMMEDIATA	 
1141	29-gen-2026 15.34.13	IMMEDIATA	 
1120	28-gen-2026 10.13.53	IMMEDIATA	 
1100	26-gen-2026 15.53.11	IMMEDIATA	 

- 3) È visualizzabile lo stato di avanzamento del download del progetto desiderato. Poiché di default risulta 'NUOVA', procedere con un refresh dello stato.

Query		Parametri		
ID	Nome	Stato	Data Stato	
1315	TE01  TEST Lesioni	NUOVA	2-feb-2026 17.26.39	 

Gli stati visibili, successivi a 'NUOVA', sono 'IN_LAVORAZIONE' nel caso in cui l'esecuzione della query sia ancora in corso e infine 'CONCLUSA' quando è terminata.

4) Cliccare sull'apposita icona di download.

Query		Parametri		
ID	Nome	Stato	Data Stato	
1315	TE01  TEST Lesioni	CONCLUSA	2-feb-2026 17.48.28	  